Módulo 2

Portaria 344/98 e medicamentos controlados

Regras vigentes em outubro de 2026 para prescrição, dispensação, guarda e escrituração de medicamentos controlados: listas do Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998 (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026), Portaria SVS/MS 6/1999, receituários físicos e eletrônicos da RDC 1.000/2025, SNCR (RDC 873/2024), SNGPC (RDC 22/2014) e penalidades da Lei 6.437/1977.

- Estrutura da Portaria 344/98 e conceitos
- Listas do Anexo I e adendos
- Receituários de controle especial
- Dispensação de controlados no balcão
- Escrituração, guarda e inventário
- SNGPC
- SNCR
- Infrações e penalidades

Estrutura da Portaria 344/98 e conceitos

A **Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998**, aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Ela foi editada pela antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e, desde a criação da Anvisa (Lei nº 9.782/1999), é atualizada por Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC). Quem trabalha no balcão lida com ela todos os dias: é a 344 que define o que é controlado, qual receituário cada medicamento exige, quanto pode ser dispensado, por quanto tempo a receita vale e como a farmácia guarda e registra tudo.

A 344 não anda sozinha. A **Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999**, é a instrução normativa que detalha a execução (como preencher campos, como retirar numeração, como escriturar, o que fazer no encerramento de atividades). Em volta das duas existem normas específicas que o farmacêutico precisa conhecer pelo nome:

Norma	Assunto	Por que importa no balcão
Portaria SVS/MS 344/1998	Regulamento técnico e listas do Anexo I	Define lista, receituário, validade e quantidade
Portaria SVS/MS 6/1999	Instrução normativa da 344	Campos do dispensador, carimbo, verso, fracionamento
RDC 58/2007	Notificação de Receita B2 (anorexígenos)	Modelo próprio para a lista B2
RDC 11/2011	Talidomida	Notificação própria, só em unidade pública credenciada
RDC 22/2014	SNGPC	Escrituração eletrônica obrigatória em farmácias e drogarias
RDC 50/2014	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Dose diária máxima e termo do prescritor
RDC 873/2024	Institui o SNCR	Numeração nacional e validade nacional das notificações
RDC 1.000/2025	Receituários eletrônicos e novos modelos físicos	Notificação eletrônica, CPF do paciente, registro de uso
Lei 6.437/1977	Infrações sanitárias	Penalidades por descumprimento

Como o regulamento é organizado

O texto da 344 segue uma ordem lógica que ajuda a estudar: definições (capítulo I), autorização (II), comércio e transporte, prescrição (V, com Notificação de Receita e Receita de Controle Especial), escrituração (VI), guarda (VII), balanços (VIII), embalagem (IX), controle e fiscalização (X) e disposições finais (XI). O **Anexo I** traz as listas de substâncias. Os anexos que traziam os modelos de talonários (IX a

XII) foram revogados pela RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025 (art. 25): os modelos oficiais passaram a ser publicados no portal da Anvisa, na página do SNCR.

O Anexo I muda com frequência. A versão consolidada no sistema de legislação da Anvisa registra, em outubro de 2026, a **Atualização nº 101**, feita pela RDC nº 1.036, de 9 de julho de 2026, que incluiu a MMDPPA na lista D1 e a dimetocaína na lista F1. Antes dela vieram, em 2026, a RDC 1.011 (30/01/2026), a RDC 1.017 (20/02/2026), a RDC 1.021 (09/04/2026) e a RDC 1.023 (11/05/2026). Na prática: antes de responder a um paciente ou a uma prova, confira a lista consolidada no portal da Anvisa, porque uma substância pode ter mudado de lista há poucas semanas.

> **ATENÇÃO**
>
> Apostilas, sites de telemedicina e bancos de questões antigos costumam trazer regras revogadas: zolpidem até 10 mg em receita branca, lista C4 de antirretrovirais, visto da Vigilância Sanitária para notificação de outro estado e talonário amarelo fornecido só pela VISA. Nenhuma delas vale em outubro de 2026.

Conceitos que caem no dia a dia

- **Medicamento sujeito a controle especial**: medicamento que contém substância, planta ou fungo das listas do Anexo I da 344 (RDC 1.000/2025, art. 3º, III).
- **Notificação de Receita (NR)**: documento padronizado, numerado pela autoridade sanitária, que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação de medicamentos das listas A1, A2, A3, B1, B2 e C2 (Portaria 344, art. 35, redação da RDC 1.000/2025). A talidomida (lista C3) tem notificação própria na RDC 11/2011.
- **Receita de Controle Especial (RCE)**: receita em duas vias, sem numeração oficial no papel, para as listas C1 e C5 e para os adendos das listas A1, A2 e B1 que mandam usar RCE (Portaria 344, art. 55; Portaria 6/1999, art. 84).
- **Autorização Especial (AE)**: licença da Anvisa para atividades como extrair, produzir, fabricar, manipular, fracionar, importar, exportar ou distribuir substâncias das listas (Portaria 344, art. 2º). A drogaria que só dispensa medicamento industrializado em embalagem original opera com a Autorização de Funcionamento (AFE); a farmácia que manipula substâncias controladas precisa da AE.
- **Adendo**: parágrafo ao final de cada lista que cria exceções, por exemplo preparações de baixa concentração que passam a exigir receita mais simples, ou formas farmacêuticas que ficam proibidas.
- **Escrituração**: registro de toda entrada, saída e perda. Em farmácias e drogarias é feita no SNGPC (RDC 22/2014, art. 35).
- **SNCR**: Sistema Nacional de Controle de Receituários, instituído pela RDC nº 873, de 27 de maio de 2024. Gera e distribui a numeração das notificações e, desde 30/09/2026, registra a utilização das receitas eletrônicas.

Quem pode prescrever

A 344 prevê três prescritores: **médico**, **cirurgião-dentista** e **médico-veterinário**. O dentista e o veterinário só podem prescrever para uso odontológico e veterinário, respectivamente (Portaria 344, art. 38; art. 55, § 1º). Algumas regras restringem ainda mais:

Situação	Quem prescreve	Base
Listas A, B, C1, C5	Médico; dentista (uso odontológico); veterinário (uso veterinário)	Portaria 344, arts. 38 e 55
Retinoides sistêmicos (C2)	Médico	Portaria 344, art. 50
Talidomida (C3)	Médico cadastrado na autoridade sanitária	RDC 11/2011, arts. 11 e 24
Notificações (A, B, B2, C2)	Profissional com numeração concedida pela VISA	Portaria 344, art. 35, § 1º
Médico do Programa Mais Médicos	Registro Único do Ministério da Saúde (RMS) substitui o CRM	RDC 52/2013, citada no Perguntas e Respostas da Anvisa

A 344 não prevê enfermeiro, farmacêutico ou nutricionista como prescritores de medicamentos das suas listas. O campo do Coren que a Anvisa incluiu no SNGPC em 2025 refere-se a antimicrobianos (receita sujeita à retenção da RDC 471/2021), prescritos nos casos amparados por protocolo.

O QUE DIZ A NORMA

"As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente." (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 38)

Validade nacional da receita

A Lei nº 13.732/2018 alterou o art. 35 da Lei nº 5.991/1973: o receituário vale em todo o território nacional, inclusive o de controle especial. A Anvisa, no Ofício nº 39/2019/GPCON, esclareceu que a validade nacional diz respeito à dispensação e que o prescritor precisa estar regular no conselho do estado onde atua. Em 2024 a RDC 873 reescreveu os arts. 41 e 50 da 344 (Notificação A e notificação de retinoides valem 30 dias em todo o território) e revogou as regras que obrigavam a farmácia a levar à VISA, em 72 horas, a Notificação A e a RCE de outro estado para visto. Em 2025 a RDC 1.000 deu a mesma redação nacional à Notificação B (art. 45).

NO BALCÃO

Receita de outro estado é aceita normalmente, com os mesmos critérios de uma receita local. Confira o conselho e a UF do prescritor, a numeração (quando for notificação) e os demais campos. Não exija carimbo de visto: essa exigência foi revogada em 2024. A única situação que ainda pede visto em 72 horas é a receita de emergência em papel não oficial.

Tarjas e embalagens

Os medicamentos das listas A e B saem com tarja preta; os das listas C1, C2 de uso sistêmico e C5, com tarja vermelha e a frase de venda sob prescrição com retenção da receita. As frases de alerta de bula e rótulo hoje seguem as RDC 768/2022 e 770/2022, que reescreveram a parte de rotulagem da 344. A

drogaria vende controlado só na embalagem original, intacta e inviolável, e não pode fracioná-la (Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109). A tarja ajuda a triagem, mas quem manda é a lista: o zolpidem, por exemplo, passou de tarja vermelha para preta com a mudança de 2024, e embalagens antigas ainda podem aparecer.

CASO

Um dentista prescreve, em Receita de Controle Especial, carbamazepina para um paciente com neuralgia do trigêmeo. A dispensação é possível: a indicação tem relação com a odontologia e a carbamazepina está na lista C1. Se o mesmo dentista prescrevesse sertralina para depressão, a farmácia deveria recusar, porque o uso não é odontológico (Portaria 344, art. 55, § 1º).

Listas do Anexo I e adendos

O **Anexo I** da Portaria 344 reúne as listas de substâncias sob controle. Cada lista tem um título que já diz o receituário exigido, e cada uma termina com um adendo de exceções. Para o balcão, o raciocínio é sempre o mesmo: identificar a substância pela DCB, achar a lista, ler o adendo e só então decidir qual documento aceitar. A versão usada aqui é a consolidada pela Anvisa com a Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9 de julho de 2026).

Visão geral das listas

Lista	Conteúdo	Exemplos de balcão	Receituário
A1	Entorpecentes	Morfina, metadona, oxicodona, fentanila, tapentadol, buprenorfina, petidina, hidromorfona	Notificação A (amarela)
A2	Entorpecentes permitidos em concentrações especiais	Codeína, tramadol, nalbufina, diidrocodeína	Notificação A (com adendos para RCE)
A3	Psicotrópicos	Metilfenidato, lisdexanfetamina, fenfluramina, dronabinol, produtos de Cannabis regularizados	Notificação A
B1	Psicotrópicos	Alprazolam, clonazepam, diazepam, bromazepam, lorazepam, midazolam, zolpidem, zopiclona, eszopiclona, modafinila, fenobarbital	Notificação B (azul)
B2	Psicotrópicos anorexígenos	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2 (azul)
C1	Outras substâncias sujeitas a controle especial	Antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, lítio, pregabalina, gabapentina, bupropiona, coxibes, canabidiol sintético	Receita de Controle Especial em 2 vias
C2	Retinoides	Isotretinoína e acitretina orais; tretinoína e adapaleno tópicos	Notificação especial (branca) para uso sistêmico

Lista	Conteúdo	Exemplos de balcão	Receituário
C3	Imunossupressores	Talidomida, lenalidomida, pomalidomida	Notificação própria (normas específicas)
C5	Anabolizantes	Testosterona, nandrolona, oxandrolona, somatropina, gestrinona	Receita de Controle Especial em 2 vias
D1	Precursoras	Efedrina, pseudoefedrina, ergotamina, ergometrina	Receita médica sem retenção
D2	Insumos químicos	Acetona, ácido clorídrico	Controle da Polícia Federal
E	Plantas e fungos proscritos	Cannabis sativa (com exceções), Erythroxylum coca, Papaver somniferum	Proibidas, salvo exceções do adendo
F1 a F4	Substâncias de uso proscrito	F1 entorpecentes; F2 psicotrópicos; F3 precursores (fenilpropanolamina); F4 outras (dexfenfluramina, etretinato, terfenadina, lindano)	Proibidas

Situação da lista C4

A lista C4 (antirretrovirais) **não existe mais** no Anexo I. A RDC nº 103, de 31 de agosto de 2016 (Atualização nº 52), retirou os antirretrovirais do controle da 344. Os artigos 54 e 58 da Portaria, que falam em C4, permanecem no texto mas ficaram sem objeto. No SUS, a dispensação de antirretrovirais segue o formulário e o sistema do programa (SICLOM); em farmácia privada, segue a regra de medicamento sob prescrição.

O que cada lista significa na prática

- **A1 e A2**: opioides. A A1 reúne os de maior potencial de abuso. A A2 traz os que só ficam na Notificação A acima de certas concentrações: abaixo do limite do adendo, passam à RCE.
- **A3**: estimulantes e outros psicotrópicos de alto risco. Desde 2026 inclui os produtos de Cannabis regularizados pela RDC 1.015, de 2 de fevereiro de 2026, e os medicamentos registrados com derivados de Cannabis (adendos 2, 10 e 12).
- **B1**: benzodiazepínicos, hipnóticos não benzodiazepínicos, barbitúricos e afins. Lista longa, com muitos adendos.
- **B2**: anorexígenos. Além da Notificação B2 (RDC 58/2007), seguem a RDC 50/2014: dose diária máxima e Termo de Responsabilidade do Prescritor.
- **C1**: a lista mais movimentada do balcão. Antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, anestésicos gerais, inibidores seletivos da COX-2, misoprostol (só hospitalar) e outros.
- **C2**: retinoides. Os de uso sistêmico (isotretinoína, acitretina, bexaroteno) exigem notificação especial e termo; os tópicos são venda sob prescrição sem retenção (adendo 2).
- **C3**: imunossupressores teratogênicos. A talidomida não é vendida em drogaria; vai só por unidades públicas credenciadas (RDC 11/2011). Lenalidomida e pomalidomida têm norma própria (adendo 4 da

C3; a cartilha da Anvisa de setembro de 2026 cita a RDC 735/2022 para a lenalidomida).

- **C5**: anabolizantes e hormônio do crescimento. Os de uso tópico são venda sob prescrição sem retenção (adendo 2).
- **D1**: precursores. Os medicamentos são vendidos com receita médica sem retenção, como diz o título da lista.
- **E e F**: proscritos. Não podem ser prescritos nem manipulados (Portaria 344, art. 61), com as exceções da Cannabis tratadas em normas próprias.

Adendos mais cobrados

Os adendos são o ponto em que mais se erra no balcão e nas provas. A tabela traz os vigentes na Atualização nº 101, com o efeito prático.

Lista e adendo	Regra	Receituário resultante
A1, adendo 3	Preparações de ópio com até 5 mg de morfina anidra por mL (até 50 mg de ópio)	RCE (ex.: elixir paregórico)
A1, adendo 5	Oxicodona em comprimido de liberação controlada com até 40 mg por unidade	RCE; acima de 40 mg, Notificação A
A1, adendo 8	Buprenorfina em adesivo transdérmico de matriz (sem reservatório)	RCE
A1, adendo 2	Difenoxilato até 2,5 mg por unidade com atropina (no mínimo 1% do difenoxilato)	RCE
A1, adendo 4	Ópio, derivados sintéticos e difenoxilato em forma líquida ou xarope de uso pediátrico	Proibido
A2, adendo 2	Codeína, diidrocodeína, etilmorfina, folcodina e afins: até 100 mg por unidade posológica e até 2,5% nas formas indivisíveis, isoladas ou associadas	RCE (ex.: paracetamol com codeína 30 mg)
A2, adendo 3	Tramadol até 100 mg por unidade posológica, isolado ou associado	RCE
A2, adendo 5	Nalbufina até 10 mg de cloridrato por unidade posológica	RCE
A3, adendo 2	Medicamento registrado com derivados de Cannabis até 30 mg/mL de THC e 30 mg/mL de canabidiol	Notificação A
A3, adendo 12	Produto de Cannabis (RDC 1.015/2026) com THC até 0,2%	RCE
B1, adendo 2	Fenobarbital, metilfenobarbital, barbital e barbexaclona	RCE
B1, adendo 9	Perampanel	RCE

Lista e adendo	Regra	Receituário resultante
B1, adendos 14 e 15	Cetamina e escetamina: dispensação e uso só em estabelecimento de saúde; escetamina nasal administrada sob observação	Não se dispensa em drogaria
B1, adendo 16	Carisoprodol	Venda sob prescrição sem retenção
C1, adendo 2	Loperamida	Venda sob prescrição sem retenção
C1, adendo 4	Misoprostol	Compra e uso só em hospital cadastrado
C1, adendo 5	Tetracaína: tópico odontológico isolado sem prescrição; otológico com prescrição sem retenção; oftálmico com retenção	Depende da forma
C1, adendos 7 e 10	Benzidamina em spray, pastilha, colutório, gel e afins; prometazina	Fora do controle da 344
C2, adendo 2	Retinoides de uso tópico	Prescrição sem retenção
C5, adendo 2	Anabolizantes de uso tópico	Prescrição sem retenção

ATENÇÃO

O zolpidem está na lista B1 **sem adendo**. O antigo adendo que permitia receita de controle especial para apresentações de até 10 mg foi excluído pela Anvisa em 2024; desde 1º de agosto de 2024 qualquer medicamento com zolpidem exige Notificação de Receita B, e as embalagens passaram a ter tarja preta. Metilfenidato e lisdexanfetamina não têm adendo de concentração: qualquer apresentação exige Notificação A.

Como raciocinar com o adendo

Três perguntas resolvem quase todo caso: qual é a substância e a quantidade por unidade posológica; o produto é isolado ou associado; qual é a forma farmacêutica. Um comprimido de paracetamol 500 mg com fosfato de codeína 30 mg tem 30 mg de entorpecente por unidade, abaixo de 100 mg, e cai no adendo 2 da A2: RCE em duas vias. Uma ampola de tramadol 100 mg/2 mL tem 100 mg por unidade, o limite do adendo, e também vai em RCE. Já um comprimido de oxicodona de liberação controlada de 80 mg passa do limite de 40 mg e exige Notificação A.

NO BALCÃO

Quando a apresentação for nova ou rara, pesquise a DCB na lista consolidada da Anvisa e leia o adendo inteiro antes de recusar ou aceitar. O sistema de gestão da loja costuma classificar o produto pela lista, mas pode estar desatualizado depois de uma RDC recente: a decisão final é do farmacêutico.

Termos exigidos além da receita

Alguns medicamentos pedem um termo assinado por prescritor e paciente. O termo é documento separado da receita: pode ser eletrônico (assinatura avançada basta) mesmo quando a receita é de papel, e vice-versa. O que muda para a farmácia é se o termo precisa ser apresentado e se uma via fica retida. A tabela resume o quadro da cartilha da Anvisa de setembro de 2026.

Medicamento	Receituário	Termo e norma	Na farmácia
Sibutramina	Notificação B2	Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexo I)	Apresentado; 1 via retida
Anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2	Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexo II)	Apresentado; 1 via retida
Isotretinoína e outros retinoides sistêmicos	Notificação especial C2	Termo de Consentimento Pós-Informação (Portaria 344, anexos XV e XVI)	Apresentado; 1 via retida
Fenfluramina	Notificação A	Termo de Responsabilidade e Esclarecimento (RDC 1.017/2026)	Apresentado; sem via para a farmácia
Cenobamato	RCE	Termo de Responsabilidade e Esclarecimento (RDC 1.017/2026)	Não exigido na dispensação
Mavacanteno	RCE	Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (RDC 784/2023)	Apresentado; 1 via retida
Produtos de Cannabis	NR A ou RCE, conforme o THC	TCLE (RDC 1.015/2026)	Não exigido nem retido
Talidomida	Notificação de talidomida	Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (RDC 11/2011)	Apresentado; 1 via na unidade pública

Cannabis em 2026

A regulação mudou em 2026. A RDC 1.011/2026 (vigência em 4 de agosto de 2026) incluiu na lista C1 a Cannabis sativa com THC até 0,3%, e a lista E passou a ter adendos que remetem os produtos de Cannabis regularizados (RDC 1.015/2026) e os medicamentos registrados para a lista A3. Pelo adendo 12 da A3, incluído pela RDC 1.023/2026, os produtos com THC até 0,2% são prescritos em RCE; acima disso, em Notificação A. A cartilha da Anvisa de setembro de 2026 registra que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desses produtos fica com prescritor e paciente e não é retido pela farmácia.

CASO

Cliente de 52 anos apresenta Receita de Controle Especial de tramadol 50 mg com paracetamol 325 mg, 60 comprimidos, posologia de 1 comprimido a cada 8 horas. O tramadol está na A2, mas o adendo 3 permite RCE porque há 50 mg por unidade. A quantidade corresponde a 20 dias, dentro do limite de 60 dias da RCE. A dispensação é regular, conferidos os demais campos.

Receituários de controle especial

Cada lista tem um receituário próprio. Saber reconhecer o modelo, quem o fornece, quanto tempo vale e quanto pode ser dispensado é o núcleo da conferência no balcão. Em 2024 e 2025 houve três mudanças grandes: a numeração passou a ser nacional, gerada pelo SNCR (RDC 873/2024); as notificações passaram a valer em todo o território; e a RDC 1.000/2025 revogou os modelos dos anexos da 344, criou os modelos físicos novos e abriu a via eletrônica.

Quadro geral

Receituário	Listas	Validade	Quantidade máxima	Substâncias por receita
Notificação A (amarela)	A1, A2, A3	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 30 dias de tratamento	1
Notificação B (azul)	B1	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 60 dias de tratamento	1
Notificação B2 (azul)	B2	30 dias	30 dias; sibutramina 60 dias	1
Notificação especial de retinoides (branca)	C2 sistêmicos	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 30 dias	1
Notificação de talidomida (branca)	C3 (talidomida)	20 dias, todo o país	30 dias de tratamento	Só talidomida
Receita de Controle Especial (branca, 2 vias)	C1, C5 e adendos de A1, A2, B1	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 60 dias por substância; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes até 6 meses	Até 3

Fontes da tabela: Portaria 344, arts. 35, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57 e 59 (redações das RDC 873/2024 e 1.000/2025); RDC 58/2007; RDC 50/2014, art. 5º (redação da RDC 133/2016); RDC 11/2011, art. 21.

Quem fornece a numeração e quem imprime

Até 2025 a Notificação A era impressa e entregue pela Vigilância Sanitária, com carimbo nas folhas. Isso mudou. Desde 13 de fevereiro de 2026, data de vigência da RDC 1.000/2025, **todos os talonários de controlados podem ser impressos em gráfica pelo próprio prescritor ou pela instituição, à sua custa**, seguindo o modelo oficial do portal da Anvisa (Portaria 344, arts. 40 e 45, redação da RDC 1.000/2025). O que continua obrigatório é a **numeração fornecida pela autoridade sanitária local**, que desde 1º de julho de 2025 é gerada no SNCR.

- **Notificação A e talidomida**: o prescritor se cadastra na VISA, recebe a numeração pelo SNCR (com comprovante eletrônico) e manda imprimir. A VISA pode continuar imprimindo, se quiser: virou faculdade, não obrigação. Blocos já impressos pela VISA valem por prazo indeterminado (RDC 1.000/2025, art. 19).

- **Notificação B, B2 e retinoides**: o profissional retira a numeração na VISA do local do consultório ou da instituição e imprime em gráfica (Portaria 6/1999, art. 75).
- **Receita de Controle Especial física**: não tem numeração oficial. Pode usar o modelo da Anvisa ou outro leiaute, desde que traga escrito "Receita de Controle Especial" e todos os campos obrigatórios. Receita comum com os dados da RCE não é mais aceita para novas prescrições.

A numeração do SNCR tem 14 dígitos no padrão AAMM, tipo de notificação, código IBGE da UF e sequencial (exemplo da cartilha da Anvisa: 2509.1-53.0012345). Por isso a sigla da UF deixou de ser um campo impresso separado (RDC 1.000/2025 revogou a alínea "a" do art. 36). Numeração física só serve para papel e numeração eletrônica só serve para receita eletrônica.

Modelos físicos em circulação

Versão	Período de impressão	Uso
Modelos dos anexos da Portaria 344	Até 12/02/2026	Válidos até acabar o estoque já impresso
Versão 1 dos novos modelos	13/02/2026 a 17/05/2026	Válidos até acabar o estoque já impresso
Versão 2 (vigente)	Desde 18/05/2026	Obrigatória para novas impressões

A cartilha da Anvisa para farmácias (setembro de 2026) orienta: usar modelo anterior não é, sozinho, motivo de recusa, desde que tenha sido impresso quando estava vigente. A data de impressão não é campo obrigatório.

Campos obrigatórios da Notificação de Receita

O art. 36 da 344, com a redação da RDC 1.000/2025, lista os campos. Os itens de numeração e de identificação do emitente vêm impressos; o restante é preenchido pelo prescritor e, no verso ou por carimbo, pela farmácia.

- Identificação numérica: sequência concedida pela autoridade sanitária.
- Emitente: nome do profissional, inscrição no conselho com a sigla da UF, endereço completo e telefone; ou nome da instituição, CNPJ (ou CNES, se pública), endereço e telefone. O endereço do consultório ou da residência do profissional é obrigatório nos modelos da versão 2 (Lei 5.991/1973, art. 35).
- Paciente: nome e **CPF**, ou passaporte se estrangeiro; no uso veterinário, nome e CPF do proprietário e identificação do animal. Sem CPF, o prescritor pode anotar "não possui" (Perguntas e Respostas da Anvisa sobre a RDC 1.000/2025). Os modelos da versão 2 trazem também o endereço do paciente.
- Medicamento ou substância pela DCB, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, **quantidade em algarismos arábicos e por extenso** e posologia.
- Símbolo de gestante cortada ao meio e a advertência sobre defeitos no feto, nas notificações de retinoides.
- Data da emissão e assinatura do prescritor (se o nome não estiver impresso, identificação legível ou carimbo).

- Identificação do comprador: nome e CPF, ou passaporte; endereço completo e telefone.
- Identificação do estabelecimento dispensador: nome, CNPJ (ou CNES), endereço, nome do responsável pela dispensação e data.
- Identificação da gráfica: nome, endereço e CNPJ no rodapé.
- Quantidade aviada anotada no verso e, em fórmula magistral, o número de registro da receita.

PONTO-CHAVE

A Notificação é **personalizada e intransferível** e contém uma única substância ou um único medicamento (Portaria 344, art. 35, § 7º). Precisa estar legível, sem emenda ou rasura, com a quantidade em algarismos e por extenso (§ 3º). A farmácia só dispensa com todos os itens preenchidos (§ 4º). A notificação fica retida e a receita que a acompanha volta ao paciente carimbada (§ 5º).

Notificação de Receita A

Cor amarela, para as listas A1, A2 e A3. Vale 30 dias a partir da emissão em todo o território nacional (art. 41, redação da RDC 873/2024). Pode conter até 5 ampolas ou, nas demais formas, a quantidade para 30 dias de tratamento (art. 43). Acima disso, o prescritor entrega justificativa com CID ou diagnóstico, posologia, data e assinatura, e a farmácia a envia junto com a notificação à VISA na Relação Mensal de Notificações de Receita A (art. 43, §§ 1º e 2º). Quando em papel, a notificação vem acompanhada de receita (art. 35).

Notificação de Receita B e B2

Cor azul. A **B** serve à lista B1: 30 dias em todo o território (art. 45, redação da RDC 1.000/2025), até 5 ampolas ou 60 dias de tratamento (art. 46). A **B2** é a notificação dos anorexígenos (RDC 58/2007): até 30 dias de tratamento, com exceção da sibutramina, que pode chegar a 60 dias (RDC 50/2014, art. 5º, §§ 1º e 2º). Os medicamentos da RDC 50/2014 têm dose diária máxima (sibutramina 15 mg/dia; anfepramona 120 mg/dia; femproporex 50 mg/dia; mazindol 3 mg/dia) e exigem **Termo de Responsabilidade do Prescritor** em 3 vias: prontuário, farmácia e paciente (art. 6º). É proibido associar anorexígenos entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios, laxantes e outras substâncias (Portaria 344, art. 47).

Notificação de Receita Especial para retinoides

Cor branca, para retinoides de **uso sistêmico** da lista C2 (isotretinoína, acitretina, bexaroteno). Vale 30 dias em todo o território e cobre até 5 ampolas ou 30 dias de tratamento (art. 50, redação da RDC 873/2024). É acompanhada do Termo de Consentimento Pós-Informação (anexos XV e XVI da 344), que pode ser eletrônico com assinatura avançada (art. 50, § 3º). A cartilha da Anvisa indica termo em 3 vias, uma retida pela farmácia. No modelo novo não há mais o campo "tratamento inicial ou subsequente" nem a substância pré-impressa: o prescritor escreve o nome.

Notificação de Receita de Talidomida

Cor branca, em 2 vias, regida pela RDC 11/2011. Vale 20 dias em todo o território (art. 21, § 2º, redação da RDC 873/2024) e cobre no máximo 30 dias de tratamento (§ 3º). Só pode conter talidomida e vem com o Termo de Responsabilidade/Esclarecimento em 3 vias (prontuário, unidade dispensadora, paciente). A

talidomida não tem venda comercial; a dispensação ocorre apenas em unidades públicas credenciadas, o que tira esse modelo da rotina da drogaria. Mesmo assim cai em prova.

Receita de Controle Especial

Branca, em 2 vias: a 1ª fica retida na farmácia e a 2ª volta ao paciente com o carimbo do atendimento (Portaria 344, arts. 52 e 53; Portaria 6/1999, art. 84). Vale 30 dias em todo o território. Até 3 substâncias da C1 por receita (art. 57), cada uma limitada a 5 ampolas ou 60 dias; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, até 6 meses (art. 59). Acima disso, justificativa com CID ou diagnóstico e posologia, datada e assinada nas duas vias (art. 60). Serve para C1, C5 e para os adendos que mandam usar RCE (codeína, tramadol, fenobarbital e outros).

O QUE DIZ A NORMA

"A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, devendo conter somente uma substância das listas [...] ou um medicamento que as contenham." (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 35, § 7º)

Receita eletrônica de controlados

A RDC 1.000/2025 permite emitir em meio eletrônico as Notificações A, B e B2, a de retinoides, a de talidomida, a RCE e a receita sujeita à retenção (art. 2º). As regras centrais:

- Emissão só em serviço de prescrição eletrônica integrado ao SNCR por API; serviço não integrado não pode emitir (art. 4º).
- Cada receita tem numeração individual concedida pelo SNCR e segue o modelo eletrônico da Anvisa (art. 7º). Para notificações, o prescritor pede a cota de numeração eletrônica à VISA; o serviço de prescrição consome essa cota. Para RCE e receita sujeita à retenção, o SNCR gera o número automaticamente.
- Notificação e RCE eletrônicas exigem **assinatura qualificada ICP-Brasil** (art. 8º; Lei 14.063/2020, art. 13). Receita sujeita à retenção aceita assinatura avançada, como a do gov.br (art. 11).
- A notificação eletrônica dispensa a receita que acompanhava a de papel (art. 9º). RCE e receita de retenção eletrônicas não têm duas vias (art. 10).
- A data da assinatura eletrônica é a data de emissão, de onde conta a validade (art. 12).
- Papel escaneado, foto de receita ou documento físico assinado digitalmente depois **não** são receita eletrônica (art. 2º, parágrafo único).

O SNCR passou a oferecer a numeração eletrônica e o registro de uso em 30 de setembro de 2026 (art. 16, redação da RDC 1.028, de 1º de junho de 2026). Antes dessa data só RCE e receita de retenção podiam ser eletrônicas; as notificações eram apenas em papel. Pelo art. 18, RCE e receita de retenção eletrônicas sem número do SNCR ainda foram aceitas por 30 dias a partir dessa data, ou seja, até o fim de outubro de 2026; uma receita assim emitida dentro da janela continua dispensável enquanto estiver no prazo de validade.

NO BALCÃO

Paciente mostra no celular uma "Notificação B" em PDF. Antes de tudo, confirme se é nato-digital: tem número do SNCR, QR Code e assinatura ICP-Brasil validável no Validar do ITI. Se for foto de um talão azul, não é receita eletrônica e não pode ser aceita; peça a via original em papel.

Receita de emergência

Em emergência, medicamento sujeito a notificação pode ser aviado com receita em papel não oficial, desde que traga diagnóstico ou CID, justificativa do caráter emergencial, data, inscrição no conselho e assinatura identificada. A farmácia anota a identificação do comprador e apresenta a receita à VISA em até 72 horas para visto (art. 36, § 2º). A regra existe também para a C1 (art. 55, § 2º). A RDC 1.000/2025 manteve essa via só para o papel e deixou claro que ela não substitui a obtenção regular de numeração.

CASO

Médica prescreve clonazepam 2 mg, 1 comprimido à noite, 90 comprimidos, em Notificação B. São 90 dias de tratamento, acima do limite de 60 dias. Sem justificativa com CID ou diagnóstico, data e assinatura entregue junto (art. 46, § 1º), a farmácia não deve dispensar a quantidade integral. Com a justificativa, a dispensação dos 90 comprimidos é regular.

Dispensação de controlados no balcão

Dispensar um controlado é uma sequência de conferências. Cada etapa tem base normativa, e o erro em qualquer uma delas transforma a venda em infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XI). A ordem abaixo segue a lógica da cartilha da Anvisa para farmácias (setembro de 2026) e os arts. 35, 36, 52 e 55 da Portaria 344.

Conferência passo a passo

1. **Identificar o medicamento e a lista.** DCB, concentração por unidade, forma farmacêutica e adendo. Isso define o receituário exigido.
2. **Conferir o tipo de documento.** Notificação da cor e do modelo certos; RCE identificada como "Receita de Controle Especial". Receita comum não serve para medicamento da 344 (Perguntas e Respostas da Anvisa, 2ª edição, perguntas 67 e 68).
3. **Verificar o modelo.** Modelo antigo, versão 1 ou versão 2, desde que impresso no período em que estava vigente.
4. **Conferir a numeração** (notificações). Se tiver o padrão do SNCR, consultar na base nacional: número idêntico, situação "autorizada", tipo correto, meio "físico" para papel, prescritor ou instituição iguais aos do documento. Numeração anterior ao SNCR não aparece no sistema e isso, sozinho, não invalida.
5. **Conferir o prescritor.** Nome, conselho e UF, endereço, assinatura. Dentista e veterinário só para uso odontológico ou veterinário.
6. **Conferir o paciente.** Nome e CPF (ou passaporte; "não possui" é aceito). No uso veterinário, proprietário e animal.

7. **Conferir a prescrição.** DCB ou nome do medicamento, concentração, forma, quantidade em algarismos e por extenso, posologia. Uma substância por notificação; até três na RCE.
8. **Conferir data e validade.** Contar os dias a partir da emissão (no eletrônico, da assinatura).
9. **Conferir a quantidade.** Dentro do limite de dias ou ampolas, ou acompanhada de justificativa.
10. **Conferir exigências específicas.** Termos (retinoides, B2, talidomida, fenfluramina), receita que acompanha a notificação em papel, restrições de local (cetamina e escetamina só em estabelecimento de saúde; misoprostol só hospitalar).
11. **Identificar o comprador** com documento.
12. **Dispensar, anotar, carimbar, reter e escriturar.**

Rasura, legibilidade e quantidade

A Notificação e a RCE devem estar legíveis, com quantidade em algarismos arábicos e por extenso, **sem emenda ou rasura** (art. 35, § 3º; art. 52, § 1º). Divergência entre o número e o extenso, corretivo, letra sobreposta ou campo em branco impedem a dispensação, porque a farmácia só pode aviar com todos os itens preenchidos (art. 35, § 4º; art. 52, § 2º). Não cabe ao balconista completar ou corrigir: o paciente volta ao prescritor.

> **ATENÇÃO**
>
> Dispensar notificação rasurada, ilegível ou incompleta é aviar receita em desacordo com a norma, infração prevista na Lei 6.437/1977 (art. 10, XI), com pena que vai de advertência a cancelamento da licença e multa.

Identificação do comprador

Quem compra pode ser o próprio paciente ou outra pessoa. Na Notificação, a farmácia registra nome e CPF (ou passaporte) do comprador, endereço completo e telefone (art. 36, "i"; Portaria 6/1999, art. 82, "a"). Na RCE, os dados do comprador e do estabelecimento podem ser apostos por carimbo e preenchidos pela farmácia (Portaria 6/1999, art. 85, "c"). Peça documento oficial com foto e confira com o que será escrito. Em receita eletrônica, o SNCR exige CPF válido do comprador para registrar a utilização; estrangeiro sem CPF não consegue comprar com receita puramente eletrônica e deve trazer receita em papel (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 73).

Carimbo, verso e destino das vias

Os modelos novos tiraram do corpo da notificação os campos do estabelecimento dispensador: tudo vai para o verso ou para o carimbo. A Portaria 6/1999, art. 82, define o que a farmácia registra:

- carimbo do estabelecimento com CNPJ (ou CNES), nome e endereço completo, data e nome legível do responsável pelo atendimento abaixo do carimbo;
- carimbo próprio no verso com a **quantidade dispensada** e, em fórmula magistral, o número de registro da receita;
- para medicamento genérico, o nome do fabricante no campo de dispensação da RCE (Perguntas e Respostas, 1ª edição, pergunta 33).

Documento	Fica na farmácia	Volta ao paciente
Notificação em papel (A, B, B2, retinoides)	A notificação	A receita que a acompanha, carimbada
Receita de Controle Especial em papel	1ª via	2ª via, carimbada
Termo da RDC 50/2014 (B2)	1 via	1 via (a outra fica no prontuário)
Termo de retinoides (3 vias)	1 via	Demais vias conforme o termo
Receita eletrônica com número SNCR	Registro de utilização no SNCR, guardado em meio eletrônico	O arquivo continua com o paciente, já marcado como utilizado

Receita de outra UF

Desde a RDC 873/2024 não há visto para receita de outro estado: a Notificação A, a de retinoides e a RCE valem em todo o país, e a RDC 1.000/2025 estendeu a redação à Notificação B. A Anvisa reforça que prescrições de outros municípios e estados, inclusive de sistemas públicos como o e-SUS, seguem os mesmos critérios das locais (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 72). Normas estaduais complementares podem existir; o Ofício 39/2019 da Anvisa admite que o estado aplique regras próprias desde que não inviabilizem a validade nacional.

Emergência, internação e entrega remota

- **Emergência**: receita em papel não oficial com CID ou diagnóstico, justificativa, data, inscrição e assinatura; a farmácia anota o comprador e leva à VISA em 72 horas (art. 36, § 2º; art. 55, § 2º).
- **Paciente internado**: dispensa a notificação; vale a prescrição do estabelecimento (art. 35, § 6º). Na alta, volta a exigência do receituário próprio.
- **Entrega remota**: permitida pela RDC 812/2023 (arts. 34-A e 34-B da 344). A farmácia busca a notificação ou a RCE no endereço do paciente, ou recebe a receita eletrônica, e só entrega o medicamento depois que o farmacêutico confere a regularidade. Compra e venda de controlados pela internet continuam proibidas (art. 34-B, § 1º).

Quantidade dispensada e fracionamento

A farmácia dispensa até a quantidade prescrita e registra no verso o que entregou. A drogaria não fraciona embalagem de controlado (Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109, § 1º); injetável pode ser dispensado pelo número de unidades da prescrição (art. 109, § 2º). Fracionamento só em farmácia, por farmacêutico, conforme legislação específica (art. 110). Notificação e RCE são de **uso único**: retida a via, não há saldo para buscar depois, e o SNCR não admite registro parcelado de notificação ou RCE eletrônica (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 74).

CASO

RCE de escitalopram 10 mg, 1 comprimido ao dia, 60 comprimidos. A loja tem só caixas de 30. O farmacêutico dispensa 2 caixas (60 comprimidos), anota "60 comprimidos" no verso da 1ª via, carimba as duas vias, retém a 1ª e devolve a 2ª. Se o paciente quisesse levar só uma caixa, a 1ª via seria retida do mesmo jeito e a segunda caixa exigiria nova receita.

Devolução e troca

Medicamento controlado que saiu da farmácia não volta para o estoque de venda. A orientação do CFF ao divulgar a retomada do SNGPC é que troca e devolução de controlados não são permitidas, salvo desvio de qualidade comprovado. Quando o tratamento é interrompido, a Portaria 6/1999 (art. 90) prevê que o paciente entregue as sobras à Vigilância Sanitária, que dá o destino (inutilização ou doação). Na prática, oriente o paciente a procurar a VISA ou o ponto de descarte indicado por ela.

NO BALCÃO

Antes de recusar uma receita, diga ao cliente exatamente o que está errado e o que ele deve pedir ao prescritor ("falta a quantidade por extenso", "a validade venceu ontem", "esta substância exige notificação azul"). A recusa bem explicada evita a ida a outra farmácia com o mesmo documento irregular e protege o paciente.

CASO

Rapaz de 19 anos traz Notificação A de metilfenidato 10 mg emitida há 32 dias, em nome da mãe, com CPF dela. A notificação venceu (30 dias, art. 41). O fato de o comprador ser outra pessoa não é problema: basta registrar os dados dele. A dispensação deve ser recusada pelo vencimento, com orientação para nova consulta.

Escrituração, guarda e inventário

Dispensar é metade do controle. A outra metade é provar, a qualquer momento, que o estoque físico de cada controlado bate com o que entrou, saiu e foi perdido. A Portaria 344 trata disso nos capítulos de escrituração (VI), guarda (VII) e balanços (VIII); a RDC 22/2014 trouxe a escrituração para o SNGPC; e a Portaria 6/1999 detalha a rotina e a troca de responsável técnico.

Guarda

Substâncias e medicamentos das listas devem ficar **sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo**, sob responsabilidade do farmacêutico (Portaria 344, art. 67). Na drogaria isso significa armário ou sala trancados, de uso só para controlados, com a chave sob controle do farmacêutico. O local de guarda da talidomida deve armazenar exclusivamente substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial (RDC 11/2011).

- Controlado não fica em gôndola, vitrine nem no balcão de atendimento.
- A chave não circula entre atendentes sem controle do farmacêutico.

- Medicamento vencido, avariado ou recolhido sai do estoque de venda, mas continua sob chave, segregado e identificado, até a destinação.

ATENÇÃO

Controlado fora do armário, sem nota fiscal ou documento hábil, pode ser apreendido, e o portador responde administrativamente (Portaria 344, art. 33). Nas listas A, B e D1, a VISA encaminha cópia do processo à autoridade policial.

Responsabilidade técnica

A escrituração é de responsabilidade do farmacêutico responsável técnico ou do substituto cadastrado e associado no SNGPC (RDC 22/2014, art. 10, § 1º). O RT pode delegar a digitação a terceiros, sob sua responsabilidade, mas a geração e o envio dos arquivos são funções dele (art. 18). A senha é pessoal e intransferível; o uso indevido recai sobre o RT e o responsável legal (art. 7º).

A troca de RT tem rito próprio. O farmacêutico que sai apresenta à VISA o levantamento do estoque de controlados até o último dia de trabalho (Portaria 6/1999, art. 113). No SNGPC, a substituição é precedida da finalização do inventário; o novo RT confere o inventário, corrige divergências antes de começar e informa a VISA (RDC 22/2014, art. 12). Na ausência do RT sem substituto, as transmissões continuam com arquivos sem movimentação de controlados ao fim do período (art. 11).

Livros e escrituração eletrônica

O texto original da 344 exige Livro de Registro Específico para farmácias e drogarias e Livro de Receituário Geral para farmácias magistrais, com termos de abertura e encerramento lavrados pela VISA (arts. 62 e 63). Cada página do livro registra uma só substância ou medicamento, pela DCB combinada com o nome comercial, em ordem cronológica de estoque, entradas, saídas e perdas (arts. 63, § 3º, e 65). A escrituração deve ser legível, sem rasuras, atualizada semanalmente (art. 64, § 1º).

Para farmácias e drogarias, a RDC 22/2014 substituiu o livro pela escrituração no SNGPC (art. 35). O livro só sobrevive em exceções: município sem acesso à internet, com autorização da VISA (art. 35, § 1º); e, no sistema informatizado da loja, apresentações fracionáveis e medicamentos com inconsistência cadastral (§ 3º). As farmácias públicas que dispensam com ressarcimento, como as do Farmácia Popular, escrituram antimicrobianos em livro ou sistema aprovado pela VISA em até 7 dias (RDC 471/2021, art. 15, redação da RDC 973/2025).

PONTO-CHAVE

O estoque físico de cada controlado deve ser **qualitativa e quantitativamente idêntico** ao escriturado no SNGPC e no sistema da loja, respeitado o prazo de escrituração (RDC 22/2014, art. 15). Todo estoque movimentado deve estar escriturado, comercializável ou não (art. 16).

Balanços e relações

A 344 ainda prevê documentos periódicos enviados à VISA. Na drogaria, dois interessam:

Documento	Conteúdo	Prazo na Portaria 344
BMPO (Balanço de Medicamentos Psicoativos e Outros Sujeitos a Controle Especial)	Vendas de medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2	Trimestral, até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro; anual até 31 de janeiro (art. 69)
RMNRA (Relação Mensal de Notificações de Receita A)	Notificações A retidas, entregues com as próprias notificações	Mensal, até o dia 15; VISA devolve as notificações em 30 dias (art. 72)

Esses artigos continuam no texto da 344, e a própria Anvisa, no Perguntas e Respostas de 2026, fala em "balanços periódicos" das listas A e B2 e admite que a VISA local peça vias impressas ou relatórios das receitas eletrônicas para conferi-los. A forma de entrega (papel, sistema estadual, relatório do SNGPC) varia entre as VISAs. Confirme a rotina com a vigilância do seu município. A falta de remessa no prazo é infração (art. 73). Notificações A eletrônicas podem ser enviadas à VISA em meio eletrônico (art. 72, § 2º-A, incluído pela RDC 1.000/2025).

Prazos de guarda

- Livros, balanços e demais documentos de movimentação de estoque: **2 anos** no estabelecimento (Portaria 344, art. 64). Inclui notificações e RCE retidas.
- Cópia de segurança da escrituração do SNGPC: 2 anos (RDC 22/2014, art. 19, I).
- Registros de utilização de receitas eletrônicas: em meio eletrônico, pelo prazo da 344 e da RDC 11/2011, disponíveis à fiscalização (RDC 1.000/2025, art. 14).
- Talidomida: prazos maiores da RDC 11/2011 (livro da unidade pública dispensadora).

Perda, furto e roubo

O SNGPC trata como **perda** a saída por vencimento, apreensão ou recolhimento pela VISA, roubo ou furto, avaria, desvio de qualidade, exclusão da lista, amostra para controle de qualidade ou análise fiscal e devolução ao fabricante (RDC 22/2014, art. 5º, XXIV). Cada uma é escriturada como perda, com o motivo.

- **Furto ou roubo de medicamento**: registrar boletim de ocorrência, comunicar a VISA, escriturar a perda com o motivo e guardar o B.O. como justificativa. A Portaria 6/1999 lista o boletim de ocorrência entre as justificativas de perda por extravio.
- **Furto, roubo ou extravio de talonário de notificação**: obrigação do responsável (prescritor ou instituição) de informar imediatamente a VISA com o B.O. (Portaria 344, art. 39). Se a farmácia souber do fato, a VISA também costuma divulgar a numeração cancelada. No SNCR, número cancelado aparece como "cancelada" e não pode ser usado.

Vencidos e inutilização

O medicamento controlado vencido é baixado como perda por vencimento e segregado sob chave. A Portaria 6/1999 cita o termo de inutilização expedido pela VISA entre os documentos que justificam a perda. A destinação final segue o plano de gerenciamento de resíduos do estabelecimento e a orientação da VISA local, que em muitos municípios exige comunicação prévia ou termo para inutilizar controlados. Não descarte em lixo comum nem devolva ao distribuidor sem documento fiscal.

NO BALCÃO

Faça contagem cega dos controlados de maior giro (clonazepam, alprazolam, zolpidem, metilfenidato) com frequência fixa, por exemplo semanal, e compare com o saldo do sistema. Divergência descoberta cedo tem explicação rastreável: nota não lançada, receita escriturada com quantidade errada, perda não registrada.

Inventário na prática

Inventário é a contagem física de todo o estoque de controlados e antimicrobianos, item a item, por lote e validade. Ele aparece em três momentos obrigatórios: no credenciamento do SNGPC (inventário inicial), na troca de responsável técnico (finalização pelo que sai e conferência pelo que entra) e no retorno às transmissões depois de um período de suspensão, quando a orientação divulgada pelo CFF foi fechar o inventário anterior e abrir um novo com contagem física. Além desses, a contagem periódica por amostragem é a ferramenta de controle interno.

1. Escolher um horário sem movimento e suspender as dispensações de controlados durante a contagem.
2. Imprimir do sistema a posição de estoque por produto, lote e validade.
3. Contar sem olhar o saldo do sistema (contagem cega), de preferência em dupla.
4. Comparar e investigar cada divergência: notas fiscais não lançadas, receitas escrituradas com erro, perdas não baixadas.
5. Corrigir os lançamentos que tiverem documento; o que não tiver explicação segue o caminho de perda, com boletim de ocorrência e comunicação à VISA quando houver suspeita de desvio.
6. Assinar e arquivar a folha de contagem com data e responsáveis.

Vencidos, avariados e recolhidos entram na contagem, porque continuam no estoque escriturado até a baixa como perda.

Encerramento de atividades

Ao fechar a loja, o estabelecimento entrega os controlados à VISA com relação em 2 vias (quantidades, lotes, validades) ou transfere a outro estabelecimento por nota fiscal visada pela VISA do remetente; nota ao consumidor não serve (Portaria 6/1999, art. 115). Pela RDC 22/2014 (art. 13), a transferência por encerramento, mudança de atividade ou junção é escriturada no SNGPC, e quem recebe escritura a entrada pela nota do estabelecimento que encerrou.

CASO

Na contagem de segunda-feira faltam 2 caixas de alprazolam 1 mg. O farmacêutico revisa as dispensações e acha uma Notificação B escriturada como 1 caixa quando foram entregues 3. Corrige o lançamento no sistema e no SNGPC dentro do prazo e registra a correção. Se a diferença não tivesse explicação, o caminho seria boletim de ocorrência, comunicação à VISA e escrituração da perda.

SNGPC

O **Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC)** é o sistema da Anvisa em que farmácias e drogarias escrituram eletronicamente a movimentação de medicamentos da Portaria 344 e de antimicrobianos. Ele substitui o livro de registro e permite à vigilância acompanhar, quase em tempo real, quanto de cada controlado entra e sai de cada loja.

Histórico curto

- **2007**: criado pela RDC 27/2007 para farmácias e drogarias.
- **2011**: antimicrobianos passam a ser escriturados, com a RDC 20/2011 (hoje substituída pela RDC 471/2021).
- **2014**: a RDC nº 22, de 29 de abril de 2014, revoga a RDC 27/2007 e passa a regular o sistema. Continua vigente.
- **2021**: por instabilidade técnica, a RDC 586/2021 suspende por tempo indeterminado os prazos de transmissão. As farmácias continuam obrigadas a escriturar nos registros internos.
- **2025 e 2026**: a Anvisa restabelece a transmissão obrigatória por região: Sudeste desde 1º/09/2025; Sul e Norte desde 1º/11/2025; Centro-Oeste e Nordeste desde 02/01/2026. Em 2025 o sistema ganhou o campo de inscrição no Coren para antimicrobianos prescritos por enfermeiro com amparo legal.

Em outubro de 2026, portanto, **a transmissão é obrigatória em todo o país**, e o descumprimento do cronograma é infração sanitária. A Anvisa não divulgou cronograma de integração entre SNGPC e SNCR (Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025, 2ª edição).

Abrangência

O SNGPC abrange os medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria 344 e os antimicrobianos da RDC 471/2021, cuja lista está na IN nº 360, de 23 de abril de 2025, e, desde 23/06/2025, os agonistas de GLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida, lixisenatida) incluídos na RDC 471/2021 pela RDC 973/2025 (RDC 22/2014, art. 2º). Todas as farmácias e drogarias são obrigadas (art. 3º). Farmácias públicas e de hospital ficam fora enquanto não houver módulo específico (art. 3º, parágrafo único). O adendo 14 da C1 é um exemplo de exceção pontual: molnupiravir apenas com autorização de uso emergencial fica fora do SNGPC e vai para livro.

Acesso e credenciamento

1. Cadastro do estabelecimento, do gestor de segurança, do farmacêutico RT e do responsável legal na Anvisa (art. 6º).
2. Acesso por senha pessoal e intransferível (art. 7º).
3. **Inventário inicial**: o RT declara todo o estoque de controlados e antimicrobianos em arquivo XML; isso credencia o estabelecimento (arts. 5º, XIX, e 8º).
4. Emissão do **Certificado de Escrituração Digital**, que fica impresso à disposição da fiscalização (art. 9º).

O **Certificado de Transmissão Regular** é o documento que a VISA e as distribuidoras podem pedir para atestar que a loja transmite em dia (art. 5º, VI). Algumas VISAs já o exigem na renovação da licença

sanitária.

Regras de transmissão

O QUE DIZ A NORMA

"Os dados da escrituração sanitária devem ser transmitidos eletronicamente em arquivos no intervalo de, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 7 (sete) dias consecutivos, ainda que nenhuma movimentação no estoque do estabelecimento tenha ocorrido no respectivo período." (RDC 22/2014, art. 10, § 3º)

- A transmissão é atualizada no mínimo uma vez por semana (art. 10, § 4º).
- Semana sem movimento também gera arquivo.
- Um arquivo novo só pode ser enviado depois que o anterior estiver "aceito" (a sequência é recebido, validado, aceito).
- Inconsistência que impeça o envio é notificada no próprio SNGPC; enquanto isso, as movimentações ficam no sistema da loja (art. 14).
- Instabilidade do próprio SNGPC não gera autuação por atraso (art. 33).

O que se escritura

Entradas (compra, transferência entre lojas da mesma raiz de CNPJ), saídas (venda ou dispensação, transferência, perda) e, nas farmácias de manipulação, transformação. Para insumos, o lote do fabricante (art. 10, § 5º). Na venda, os dados da receita: tipo, número, data, prescritor e conselho, paciente, comprador, medicamento, lote e quantidade. Na receita eletrônica a Anvisa manda informar o número do receituário no mesmo campo usado para o papel (Perguntas e Respostas, pergunta 35 da 2ª edição). O número do SNCR tem 14 dígitos, e o CFF divulgou a orientação de excluir os quatro primeiros dígitos (ano e mês) ao lançar números do SNCR. Siga o leiaute vigente do sistema da loja e a orientação da VISA.

Rotina diária e semanal

Quando	O que fazer
A cada dispensação	Lançar no sistema da loja os dados da receita, do comprador, lote e quantidade; conferir antes de salvar
Ao receber mercadoria	Lançar a entrada pela nota fiscal, com lote e validade, no mesmo dia
Diariamente	Revisar pendências e inconsistências; separar receitas retidas do dia por tipo
Até 7 dias do último envio	Gerar o XML, transmitir e acompanhar até "aceito"
Semanalmente	Contagem por amostragem dos itens de maior giro e comparação com o saldo
Mensalmente	Conferir arquivamento das receitas; RMNRA quando exigida pela VISA

Quando	O que fazer
Troca de RT	Finalizar inventário; novo RT confere e corrige antes de transmitir

NO BALCÃO

Lance a dispensação no momento do atendimento, com a receita na mão. Deixar para o fim do dia é a origem mais comum de quantidade errada, comprador trocado e lote inexistente. Se perceber erro depois de transmitido, corrija pelo procedimento do sistema e registre o motivo.

Sigilo dos dados

O sistema da loja deve garantir sigilo, integridade, autenticidade e disponibilidade, e é vedado repassar a terceiros dados capazes de identificar padrões de prescrição, dispensação ou consumo (RDC 22/2014, art. 21). Vender ou ceder relatórios de prescrição por médico, por exemplo, é proibido. A LGPD (Lei 13.709/2018) se soma a essa regra.

CASO

Drogaria de Fortaleza transmitiu o último arquivo numa quinta-feira e só voltou a transmitir na sexta da semana seguinte: 8 dias. Mesmo sem venda de controlado no período, o arquivo deveria ter sido enviado até a quinta. Desde 02/01/2026 a obrigatoriedade vale para o Nordeste, e o atraso pode gerar autuação, salvo se a causa for instabilidade comprovada do próprio SNGPC (art. 33).

SNCR

O **Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR)** é o sistema da Anvisa que gera, distribui e controla a numeração das receitas de controlados. Ele foi instituído pela **RDC nº 873, de 27 de maio de 2024** (DOU de 03/06/2024), entrou em funcionamento em 18 de julho de 2024 e, desde 1º de julho de 2025, é de uso obrigatório pelas Vigilâncias Sanitárias para gerar a numeração das notificações. Em 30 de setembro de 2026 começou a etapa eletrônica: o SNCR passou a numerar receitas eletrônicas e as farmácias passaram a registrar nele a utilização dessas receitas (RDC 1.000/2025, art. 16, com a data dada pela RDC 1.028/2026).

PONTO-CHAVE

O SNCR controla **a receita** (numeração, autenticidade, uso único). O SNGPC controla **o medicamento** (entradas, saídas, estoque). Os dois coexistem e um não substitui o outro.

Normas que regem o SNCR

Norma	Data	O que trouxe
RDC 873/2024	27/05/2024	Institui o SNCR; numeração nacional; validade nacional da Notificação A, de retinoides e de talidomida; fim do visto para receita de outro estado
RDC 1.000/2025	11/12/2025 (DOU 15/12/2025; vigência 13/02/2026)	Receituários eletrônicos integrados ao SNCR; novos modelos físicos; CPF do paciente; impressão em gráfica pelo prescritor; registro de uso pela farmácia
RDC 1.028/2026	01/06/2026 (DOU 02/06/2026)	Adia para 30/09/2026 a disponibilização das funções eletrônicas

Para quais receituários vale

- **Notificações físicas (A, B, B2, retinoides, talidomida)**: numeradas pelo SNCR desde 1º/07/2025. A farmácia consulta o número na base nacional para conferir, mas **não registra uso** de receita em papel.
- **Notificações eletrônicas**: existem desde 30/09/2026. Número do SNCR, emissão por serviço integrado, consulta e registro de uso obrigatório pela farmácia.
- **RCE e receita sujeita à retenção eletrônicas** (antimicrobianos, agonistas do receptor de GLP-1): passaram a receber número automático do SNCR; sem número, só foram aceitas as emitidas até o fim da janela de transição de 30 dias (RDC 1.000/2025, art. 18).
- **RCE e receita de retenção em papel**: continuam **sem número** do SNCR.

Como o prescritor obtém a numeração

Para o papel, o prescritor (ou a instituição) se cadastra na Vigilância Sanitária do local onde atende e pede a numeração. A VISA gera e atribui os números no SNCR; o comprovante eletrônico do sistema formaliza a entrega, sem necessidade de comparecer para carimbar talões (Portaria 344, art. 40, § 4º; Portaria 6/1999, arts. 69, § 3º, e 75, § 2º, redação da RDC 1.000/2025). Depois, ele manda imprimir em gráfica, no modelo oficial. Quem atende em vários estados, inclusive por telemedicina, pede numeração na VISA de cada estado onde atua (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 54).

Para o eletrônico, o prescritor pede à VISA uma cota de numeração eletrônica de notificações. O serviço de prescrição integrado consome essa cota ao emitir. O prescritor não acessa o SNCR diretamente e não pode digitar um número num modelo e gerar o documento por conta própria: notificação emitida fora de serviço integrado não deve ser aceita (pergunta 49). A emissão é pessoal: instituições e terceiros não emitem em nome do prescritor (RDC 1.000/2025, art. 6º).

Situações do número na consulta

Situação	Significado	Conduta
Autorizada	Número válido e disponível	Prosseguir com as demais conferências

Situação	Significado	Conduta
Não atribuída ao prescritor	Número de Notificação A ou talidomida gerado mas não vinculado	Não dispensar; orientar o prescritor a regularizar com a VISA
Cancelada	Cancelada pela VISA (ex.: talão furtado)	Não dispensar
Inválida	Número digitado errado ou fora do padrão	Redigitar; se for numeração anterior ao SNCR, conferir com a VISA em caso de dúvida
Receita utilizada	Receita eletrônica já registrada	Não dispensar
Receita utilizada parcialmente	Só em receita de retenção com parcelamento permitido	Dispensar o saldo se a norma específica admitir

Fonte: cartilha da Anvisa "SNCR e receituários controlados" (setembro de 2026) e Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025.

O que a farmácia confere

1. Número idêntico ao do documento.
2. Situação "autorizada".
3. Tipo de receituário igual ao apresentado.
4. Meio de emissão: físico para papel, eletrônico para receita eletrônica. Número de um meio não serve no outro.
5. Prescritor ou instituição vinculados ao número iguais ao emitente.
6. No eletrônico, também: assinatura válida no Validar do ITI (ICP-Brasil para notificação e RCE) e data da assinatura dentro da validade.

A tela do SNCR não mostra paciente nem prescrição: esses dados continuam sendo conferidos no próprio documento (pergunta 79). "Autorizada" não dispensa a conferência da validade e dos campos obrigatórios.

Registro de utilização

Na dispensação de receita eletrônica, a farmácia valida a assinatura no serviço do ITI, confere a numeração e registra a utilização no SNCR preenchendo todos os campos (RDC 1.000/2025, art. 13). O registro substitui o carimbo e a anotação no verso (Portaria 344, art. 36, § 3º; Portaria 6/1999, art. 82, parágrafo único). A guarda é eletrônica, pelo prazo da 344 (art. 14). Cada receita é usada uma única vez (art. 15). O registro pode ser cancelado pelo mesmo estabelecimento em até 30 minutos. Com o SNCR fora do ar, não há como dispensar receita eletrônica numerada: o paciente aguarda o restabelecimento (pergunta 75).

Acesso da farmácia

O acesso é pelo Cadastro Anvisa, com login gov.br individual. A farmácia privada é identificada pela **AFE** ativa; o responsável legal atribui aos colaboradores os perfis de farmácia do SNCR. Farmácias públicas e dispensários são identificados pelo CNES (perguntas 58 a 65). Sem AFE publicada no DOU não há acesso nem dispensação. A norma não fixa prazo para o primeiro acesso, mas sem cadastro a loja não consegue atender receita eletrônica.

Transição das receitas brancas eletrônicas

Receita de Controle Especial e receita sujeita à retenção já podiam ser emitidas eletronicamente antes de 30/09/2026, sem número do SNCR. Nesse formato antigo, a farmácia guarda o arquivo eletrônico original e mantém uma cópia impressa só para anotar a dispensação (comprador, fornecedor, quantidade e carimbo). A impressão não transforma a receita em papel: o documento de referência continua sendo o eletrônico. Depois do fim da janela de transição de outubro de 2026, toda nova RCE ou receita de retenção eletrônica precisa ter número do SNCR, com consulta e registro de uso no sistema. Uma receita emitida sem número durante a janela continua válida até o fim do seu prazo; a cartilha da Anvisa dá o exemplo de uma RCE emitida em 02/10/2026 que pode ser dispensada até 01/11/2026.

Proteção de dados

Receita eletrônica é dado pessoal sensível. Prescritor, plataforma e farmácia são agentes de tratamento pela LGPD (Lei 13.709/2018) e devem limitar o acesso ao necessário para a finalidade sanitária. No balcão isso significa não fotografar a receita no celular pessoal, não encaminhar o arquivo por aplicativo de mensagem fora do fluxo da loja e conceder perfil no SNCR só a quem atende controlados.

NO BALCÃO

Deixe pelo menos dois colaboradores habilitados no SNCR em cada turno, com o farmacêutico sempre entre eles, e um computador ou celular com leitor de QR Code no balcão. Receita eletrônica de controlado que chega sem conferência no SNCR é receita que não pode ser dispensada.

CASO

Paciente apresenta Notificação B em papel com número de 14 dígitos. Na consulta, o SNCR mostra "autorizada", tipo B, meio eletrônico. A dispensação deve ser recusada: um número destinado ao meio eletrônico não pode estar impresso num talão de papel.

Infrações e penalidades

Descumprir a Portaria 344, a RDC 22/2014 ou a RDC 1.000/2025 é infração sanitária. A lei que tipifica as infrações e fixa as penas é a **Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977**. As próprias normas remetem a ela (RDC 22/2014, art. 39; RDC 50/2014, art. 13; RDC 1.000/2025, art. 26), e a Portaria 344 (art. 73) trata como infração a falta de remessa de balanços e relações no prazo.

Infrações mais ligadas a controlados

Lei 6.437/1977, art. 10	Conduta	Penas previstas
Inciso XI	Aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou com determinação expressa de lei e normas regulamentares	Advertência, interdição, cancelamento de licença e/ou multa
Inciso XII	Fornecer ou vender medicamento cuja venda dependa de prescrição sem observar essa exigência	Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa
Inciso X	Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora	Advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa
Inciso XXIX	Transgredir outras normas legais e regulamentares de proteção da saúde	Advertência a cancelamento de autorização e/ou multa

Penalidades e multas

O art. 2º lista as penas, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: advertência, multa, apreensão, inutilização e interdição de produto, suspensão de vendas, cancelamento de registro, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da autorização de funcionamento e do alvará, entre outras. As multas (art. 2º, § 1º, incluído pela MP 2.190-34/2001):

Classificação	Critério (art. 4º)	Multa
Leve	Infrator beneficiado por circunstância atenuante	R$ 2.000 a R$ 75.000
Grave	Uma circunstância agravante	R$ 75.000 a R$ 200.000
Gravíssima	Duas ou mais agravantes	R$ 200.000 a R$ 1.500.000

A multa dobra na reincidência (§ 2º) e considera a capacidade econômica do infrator (§ 3º). São agravantes, entre outras: reincidência, infração para obter vantagem pecuniária, dolo ou má-fé, e deixar de agir diante de ato lesivo conhecido (art. 8º). São atenuantes: ação não fundamental para o evento, erro escusável de compreensão, reparação espontânea e infrator primário em falta leve (art. 7º). A reincidência específica permite enquadrar como gravíssima (art. 8º, parágrafo único).

Responsabilidade além da multa

- **Empresa e profissionais**: a empresa responde administrativa e civilmente; o RT e o responsável legal podem responder também (RDC 22/2014, art. 39). A VISA pode comunicar o fato ao Conselho Regional de Farmácia (art. 34), o que abre processo ético.
- **Penal**: substâncias das listas sem documento hábil são apreendidas e, nas listas A, B e D1, a VISA envia cópia do processo à polícia (Portaria 344, art. 33). Vender ou entregar droga "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" é conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006.

- **SNCR**: o serviço de prescrição que descumpre os requisitos tem o acesso suspenso de imediato (RDC 1.000/2025, art. 17).

O QUE DIZ A NORMA

"São infrações sanitárias: [...] XI - aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei e normas regulamentares." (Lei 6.437/1977, art. 10, XI)

Erros comuns que geram autuação

Erro	Norma descumprida
Dispensar controlado com receita vencida	Portaria 344, arts. 41, 45, 50, 52; RDC 11/2011
Aceitar notificação rasurada, sem quantidade por extenso ou com campo vazio	Portaria 344, art. 35, §§ 3º e 4º
Aceitar receita comum para medicamento da 344	Portaria 344, arts. 35 e 55; Portaria 6/1999, art. 84
Dispensar zolpidem com RCE (regra anterior a agosto de 2024)	Anexo I, lista B1
Dispensar quantidade acima do limite sem justificativa	Portaria 344, arts. 43, 46, 59 e 60
Não reter a notificação ou a 1ª via da RCE	Portaria 344, arts. 35, § 5º, e 53
Não identificar comprador ou não anotar quantidade no verso	Portaria 344, art. 36; Portaria 6/1999, art. 82
Controlado fora do armário com chave	Portaria 344, art. 67
Estoque físico diferente do SNGPC	RDC 22/2014, art. 15
Atraso de mais de 7 dias na transmissão	RDC 22/2014, art. 10, §§ 3º e 4º
Fracionar embalagem de controlado em drogaria	Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109
Vender controlado pela internet	Portaria 344, art. 34-B, § 1º
Dispensar receita eletrônica sem consultar e registrar no SNCR	RDC 1.000/2025, art. 13
Não arquivar receitas e documentos por 2 anos	Portaria 344, art. 64
Ceder dados de prescrição a terceiros	RDC 22/2014, art. 21, parágrafo único

Processo administrativo sanitário

A infração é apurada em processo administrativo próprio, que começa com o auto de infração lavrado pela autoridade sanitária. Os prazos principais da Lei 6.437/1977 são:

- Defesa ou impugnação do auto: 15 dias da notificação (art. 22).
- Pagamento da multa em até 20 dias da notificação: redução de 20%, com desistência tácita de defesa ou recurso (art. 21).
- Recurso contra decisão condenatória: mesmo prazo da defesa; mantida a decisão, recurso à autoridade superior em 20 dias (art. 30).
- Obrigação que subsiste após a autuação: edital com prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária (arts. 18 e 19).
- Prescrição das infrações sanitárias: 5 anos, interrompida pela notificação ou por ato de apuração (art. 38).

Na defesa, a farmácia organizada leva vantagem: receitas arquivadas por mês e tipo, relatórios do SNGPC, registros de contagem e de treinamento mostram boa-fé e podem enquadrar a falta como leve, com atenuantes do art. 7º.

Como reduzir o risco

Boa parte das autuações nasce de rotina frouxa. Um procedimento operacional padrão de dispensação de controlados, treinamento periódico da equipe com casos reais, checklist no balcão, contagem regular e transmissão do SNGPC com dia fixo resolvem a maior parte. Diante de dúvida sobre uma receita, a decisão é do farmacêutico, que deve registrar o motivo de uma recusa quando houver risco de questionamento.

NO BALCÃO

Na inspeção, apresente com tranquilidade o Certificado de Escrituração Digital, o relatório do SNGPC, as receitas retidas organizadas por mês e tipo, e o armário trancado. Dificultar o acesso do fiscal é infração própria (Lei 6.437/1977, art. 10, X).

CASO

Na fiscalização, a VISA encontra 3 caixas de clonazepam 2 mg a mais no armário do que o saldo do SNGPC e transmissões atrasadas há 20 dias. Há duas infrações: divergência de estoque (RDC 22/2014, art. 15) e atraso na transmissão (art. 10). Se a farmácia já tivesse sido autuada pela mesma conduta, a reincidência agravaria a classificação e dobraria a multa (Lei 6.437/1977, art. 2º, § 2º, e art. 8º).

Fontes consultadas

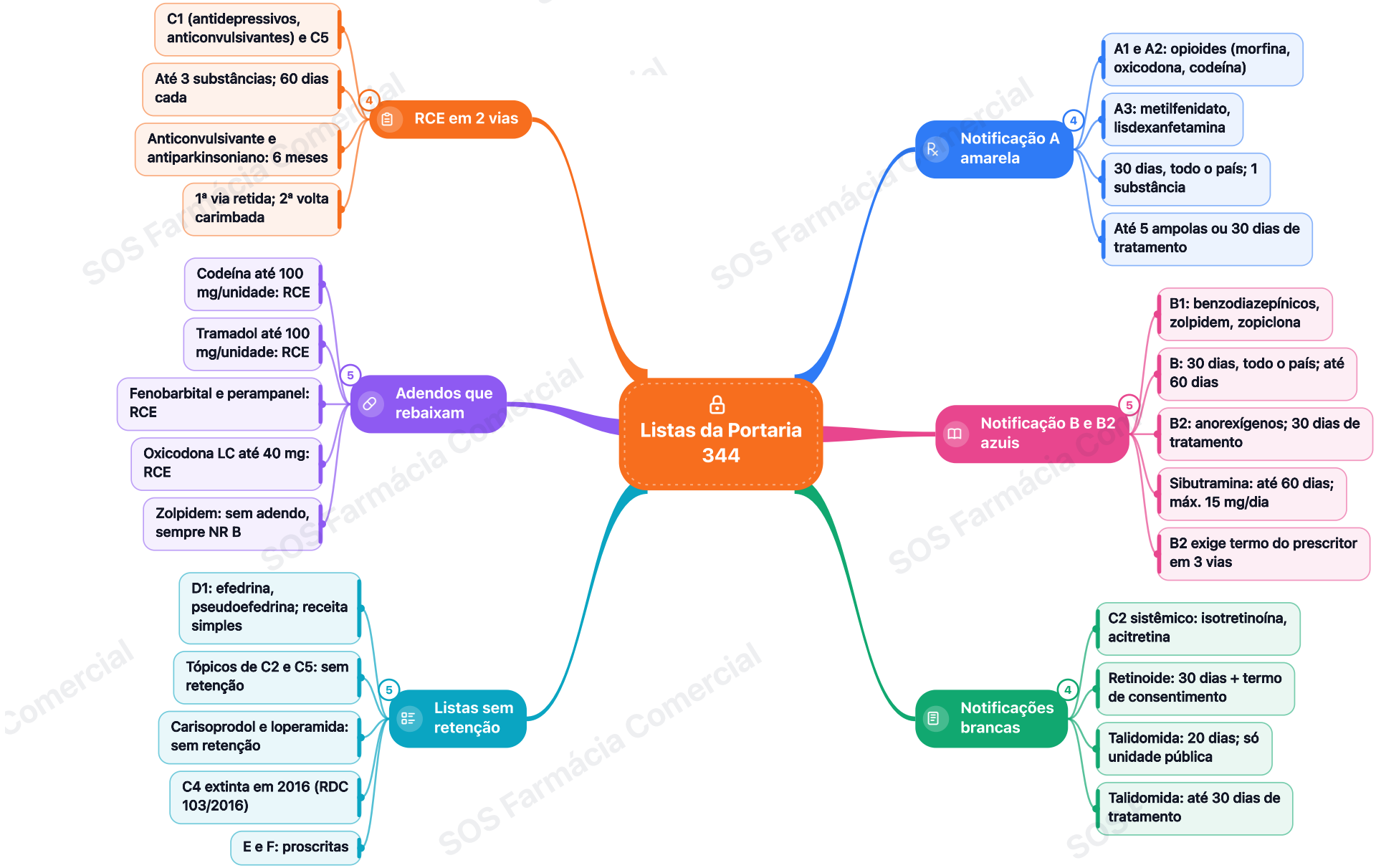
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (texto consolidado pela Anvisa até a Atualização nº 101, RDC nº 1.036, de 9 de julho de 2026). anvisalegis.datalegis.net
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 (texto consolidado pela Anvisa). anvisalegis.datalegis.net
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025. Diário Oficial da União, 15 dez. 2025. in.gov.br
4. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.028, de 1º de junho de 2026. Diário Oficial da União, 2 jun. 2026.

5. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 873, de 27 de maio de 2024 (institui o SNCR). Diário Oficial da União, 3 jun. 2024 (dispositivos conferidos no texto consolidado da Portaria 344 e da RDC 11/2011).
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 22, de 29 de abril de 2014 (SNGPC), texto consolidado. anvisalegis.datalegis.net
7. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 11, de 22 de março de 2011 (talidomida), texto consolidado. anvisalegis.datalegis.net
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 50, de 25 de setembro de 2014 (anorexígenos), texto consolidado com a RDC 133/2016. anvisalegis.datalegis.net
9. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 973, de 23 de abril de 2025 (altera a RDC 471/2021). anvisalegis.datalegis.net
10. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 360, de 23 de abril de 2025 (lista de antimicrobianos). Diário Oficial da União, 24 abr. 2025.
11. Anvisa. Perguntas e Respostas: RDC nº 1.000/2025, 1ª edição (fevereiro de 2026) e 2ª edição. gov.br/anvisa
12. Anvisa. SNCR e receituários controlados: cartilha para farmácias. 1ª ed. Brasília, setembro de 2026. gov.br/anvisa
13. Anvisa. Webinar RDC 1.000/2025: receituários eletrônicos e físicos (Vigilâncias, fevereiro de 2026; farmácias, março de 2026). gov.br/anvisa
14. Anvisa. Início de nova etapa do SNCR: o que muda a partir de 30 de setembro. Notícia, 2026. gov.br/anvisa
15. Anvisa. Ofício nº 39/2019/SEI/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA ao Conselho Federal de Farmácia: esclarecimentos sobre a Lei nº 13.732/2018. Março de 2019.
16. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (infrações à legislação sanitária federal), texto compilado. planalto.gov.br
17. Brasil. Lei nº 13.732/2018 (altera o art. 35 da Lei nº 5.991/1973), conforme Ofício Anvisa nº 39/2019.
18. Conselho Federal de Farmácia. SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Notícia, 24 out. 2025; Anvisa restabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos ao SNGPC, 6 maio 2025. cff.org.br
19. Conselho Federal de Farmácia. Qualquer medicamento contendo zolpidem deverá ser prescrito por meio de Notificação de Receita B. Notícia, 16 maio 2024. cff.org.br
20. Ministério da Saúde. Nota Informativa nº 75/2016 (exclusão dos antirretrovirais da lista C4 pela RDC nº 103/2016), citada em gov.br/aids.

SOS Farmácia Comercial

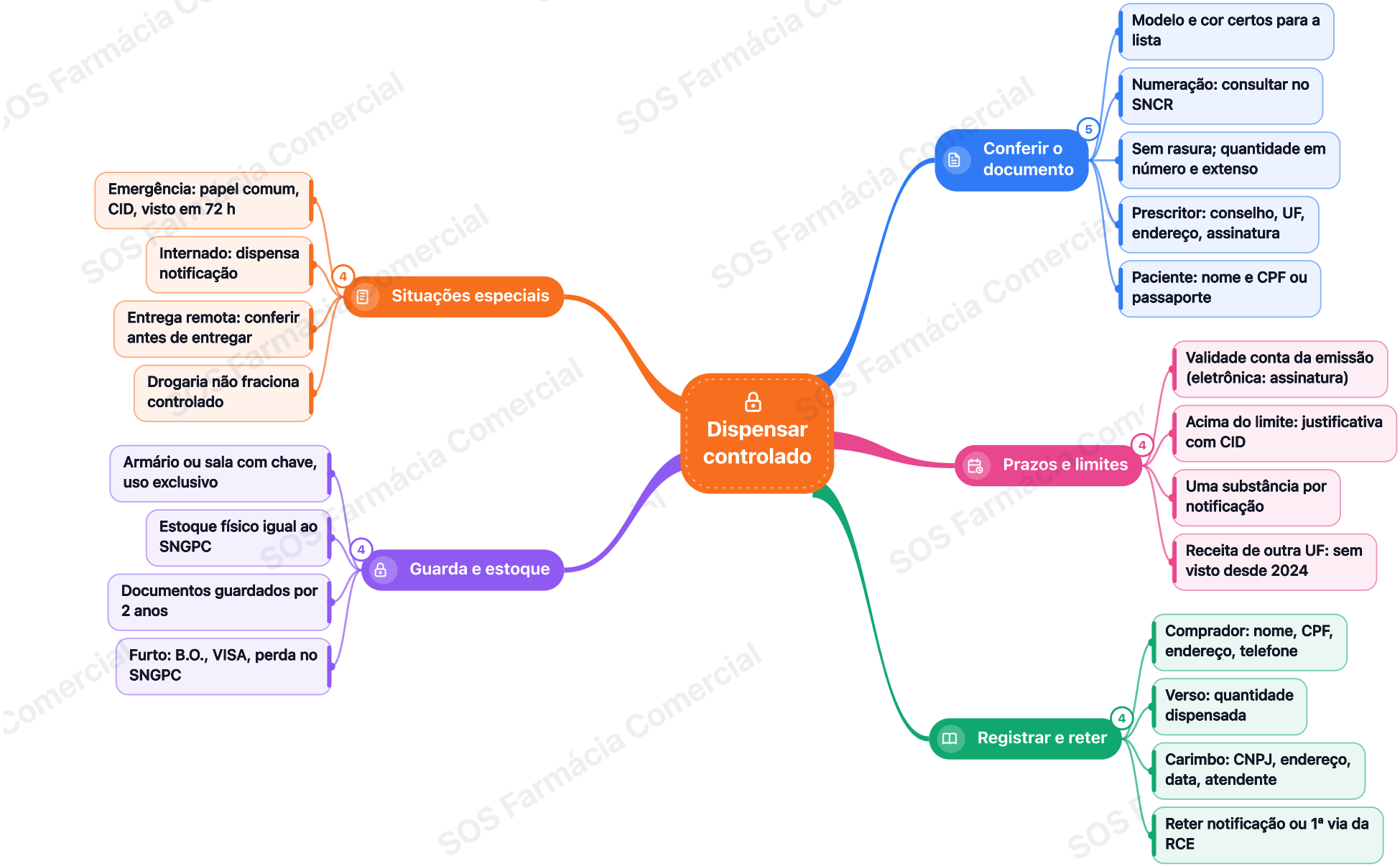
Listas e receituários

6 ramos · 27 itens · mapa mental do módulo 2



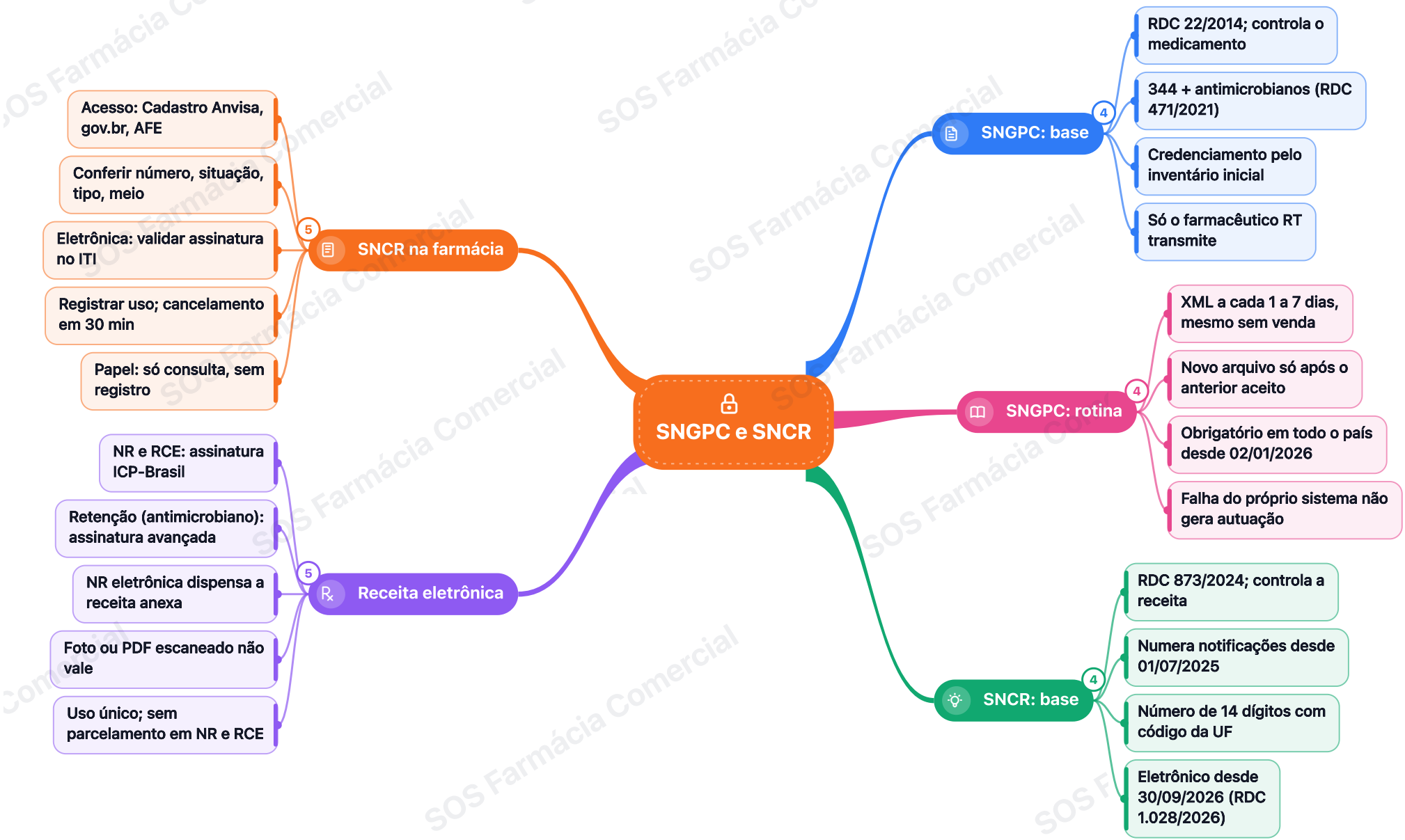
Dispensação e guarda

5 ramos · 21 itens · mapa mental do módulo 2



SNGPC e SNCR

5 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 2



Notificação de Receita A

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA A

Listas A1, A2 e A3

Nº _____

Numeração concedida pela VISA local e gerada no SNCR (14 dígitos). Impressão em gráfica pelo prescritor ou instituição; a VISA pode imprimir, se quiser (RDC 1.000/2025).

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso, sem símbolos adicionais: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor (com identificação legível ou carimbo se o nome não estiver impresso): _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

RODAPÉ

Nome, endereço e CNPJ da gráfica: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 41)
Abrangência	Todo o território nacional, sem visto (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 30 dias de tratamento; acima, justificativa com CID (art. 43)
Substâncias	Uma por notificação (art. 35, § 7º)
Acompanhamento	Em papel, vem com a receita, que volta carimbada ao paciente
Destino	Retida na farmácia; relação mensal (RMNRA) à VISA até o dia 15 (art. 72)

Modelo vigente para novas impressões: versão 2 (desde 18/05/2026). Blocos antigos impressos na vigência anterior continuam válidos. Confira o leiaute no portal da Anvisa.

Notificação de Receita B

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B

Lista B1 (psicotrópicos)

Nº _____

Numeração retirada na VISA do local do consultório ou instituição, gerada no SNCR. Impressão às expensas do profissional ou da instituição, em gráfica.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

RODAPÉ

Nome, endereço e CNPJ da gráfica: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 45)
Abrangência	Todo o território nacional (redação da RDC 1.000/2025)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 60 dias de tratamento; acima, justificativa com CID (art. 46)
Substâncias	Uma por notificação
Exemplos	Clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem (qualquer dose)
Destino	Retida na farmácia; escriturada no SNGPC

Existe modelo de Notificação B para uso veterinário, com identificação do proprietário e do animal.

SOS Farmácia Comercial

Notificação de Receita B2

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2

Lista B2 (anorexígenos)

Nº _____

Numeração da VISA local gerada no SNCR; impressão pelo prescritor em gráfica, no modelo da Anvisa (RDC 58/2007, art. 1º, redação da RDC 1.000/2025).

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

Dose diária dentro do limite da RDC 50/2014: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

ANEXO OBRIGATÓRIO

Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexos I e II), 3 vias: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão
Abrangência	Todo o território nacional (Lei 13.732/2018)
Quantidade máxima	30 dias de tratamento; sibutramina até 60 dias (RDC 50/2014, art. 5º)
Dose diária máxima	Sibutramina 15 mg; anfepramona 120 mg; femproporex 50 mg; mazindol 3 mg
Associação	Proibida com outros anorexígenos, ansiolíticos, diuréticos, hormônios, laxantes (Portaria 344, art. 47)
Termo	Farmácia preenche seus campos, retém 1 via e entrega 1 ao paciente (RDC 50/2014, art. 11)

Manipulação de anorexígenos só nas condições da RDC 50/2014 (arts. 4º e 9º).

Notificação de Receita Especial para retinoides

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL PARA RETINOIDES

Lista C2, uso sistêmico

Nº _____

Numeração da VISA local gerada no SNCR; impressão às expensas do médico ou da instituição.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Substância escrita pelo prescritor (sem campo pré-impresso): _____

Dosagem e forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

ADVERTÊNCIA

Símbolo de gestante cortada ao meio: _____

Alerta de graves defeitos na face, orelhas, coração e sistema nervoso do feto: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do médico: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 50)

Regra	Como é
Abrangência	Todo o território nacional (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 30 dias de tratamento (art. 50, § 1º)
Prescritor	Médico
Termo	Termo de Consentimento Pós-Informação (anexos XV e XVI da 344); cartilha da Anvisa: 3 vias, 1 retida pela farmácia
Tópicos	Retinoide tópico não usa esta notificação: prescrição sem retenção

No modelo novo não há mais marcação de tratamento inicial ou subsequente. Normas estaduais podem fixar validade menor para mulheres em idade fértil.

Notificação de Receita de Talidomida

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA

Lista C3, talidomida (RDC 11/2011)

Nº _____

Numeração distribuída pela autoridade sanitária via SNCR ao médico cadastrado; impressão no modelo da Anvisa, em 2 vias.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número concedido pela autoridade sanitária: _____

DIAGNÓSTICO

CID: _____

ADVERTÊNCIAS IMPRESSAS

"Proibida para mulheres grávidas ou com chance de engravidar": _____

"Talidomida causa o nascimento de crianças sem braços e sem pernas": _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome completo: _____

Endereço: _____

Especialidade: _____

CPF: _____

Número do cadastro na autoridade sanitária: _____

Data, assinatura e carimbo: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo: _____

Documento oficial e órgão emissor: _____

Data de nascimento: _____

Sexo: _____

Endereço e telefone: _____

RESPONSÁVEL PELO PACIENTE (SE HOUVER)

Nome: _____

Documento oficial: _____

Endereço e telefone: _____

MEDICAMENTO

Quantidade de comprimidos em algarismos e por extenso: _____

Dose por unidade: _____

Posologia: _____

Tempo de tratamento: _____

DISPENSAÇÃO (FARMACÊUTICO)

Quantidade e lote: _____

Nome, CRF, assinatura, carimbo e data: _____

Carimbo da unidade pública dispensadora: _____

Regra	Como é
Validade	20 dias a contar da emissão (RDC 11/2011, art. 21, § 2º)

Regra	Como é
Abrangência	Todo o território nacional (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	30 dias de tratamento (art. 21, § 3º)
Conteúdo	Somente talidomida
Termo	Responsabilidade/Esclarecimento em 3 vias: prontuário, unidade dispensadora, paciente
Onde dispensar	Somente unidade pública credenciada; venda proibida

Ordem dos campos segundo o art. 22 da RDC 11/2011. Não circula em drogaria comercial.

Receita de Controle Especial

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL
Listas C1 e C5 e adendos de A1, A2 e B1

Nº _____
Em papel não tem numeração oficial. Na via eletrônica integrada, o SNCR gera o número automaticamente.

CABEÇALHO

Dizer "Receita de Controle Especial": _____

Indicação das vias: "1ª via: retenção da farmácia" e "2ª via: orientação ao paciente": _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional ou da instituição: _____

Inscrição no conselho e UF: _____

Endereço completo e telefone (CNPJ ou CNES, se instituição): _____

Cidade: _____

PRESCRIÇÃO

Paciente: nome completo e CPF (ou passaporte): _____

Medicamento ou fórmula, dosagem, quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia ou modo de usar: _____

Data: _____

Assinatura: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Documento de identificação: _____

Endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Carimbo da farmácia (nome, CNPJ, endereço): _____

Data e nome do atendente: _____

Genérico: nome do fabricante: _____

Verso: quantidade dispensada: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 52, § 1º)
Abrangência	Todo o território nacional
Quantidade máxima	5 ampolas ou 60 dias por substância; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes até 6 meses (art. 59)
Substâncias	Até 3 por receita (art. 57)
Vias	Papel: 2 vias, 1ª retida; eletrônica: via única com registro no SNCR
Leiaute	Pode diferir do modelo da Anvisa se trouxer o título e todos os campos; receita comum não serve

Campos conforme Portaria 344, art. 55, e Portaria 6/1999, art. 85, com redação da RDC 1.000/2025. Os campos do comprador e do fornecedor podem vir por carimbo.

Tabela-mestra: lista, receituário, validade e limites

Lista	Exemplos	Receituário	Validade	Quantidade máxima	Abrangência
A1	Morfina, metadona, oxicodona, fentanila, tapentadol	Notificação A amarela	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
A2	Codeína, tramadol, nalbufina (acima dos adendos)	Notificação A; RCE nos adendos	30 dias	NR A: 5 ampolas ou 30 dias	Nacional
A3	Metilfenidato, lisdexanfetamina, fenfluramina	Notificação A amarela	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
B1	Clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem	Notificação B azul	30 dias	5 ampolas ou 60 dias	Nacional
B2	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2 azul + termo	30 dias	30 dias; sibutramina 60	Nacional
C1	Sertralina, quetiapina, carbamazepina, pregabalina, celecoxibe	RCE em 2 vias	30 dias	3 substâncias; 60 dias cada; 6 meses p/ anticonvulsivante	Nacional
C2	Isotretinoína, acitretina (sistêmicos)	Notificação especial branca + termo	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional

Lista	Exemplos	Receituário	Validade	Quantidade máxima	Abrangência
C3	Talidomida	Notificação de talidomida branca + termo	20 dias	30 dias	Nacional; só unidade pública
C5	Testosterona, nandrolona, oxandrolona, somatropina	RCE em 2 vias	30 dias	5 ampolas ou 60 dias	Nacional
D1	Pseudoefedrina, efedrina, ergotamina	Receita sem retenção	Conforme receita comum	Sem limite da 344	Nacional
E, F	Plantas e substâncias proscritas	Proibidas	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Base: Portaria 344, arts. 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59 e Anexo I (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026); RDC 50/2014; RDC 11/2011. Validade nacional: Lei 13.732/2018, RDC 873/2024 e RDC 1.000/2025. A lista C4 foi extinta pela RDC 103/2016.

Adendos que mudam o receituário

Substância	Lista	Condição do adendo	Receituário	Exemplo de balcão
Codeína e afins	A2	Até 100 mg por unidade e até 2,5% em forma indivisível	RCE	Paracetamol 500 mg + codeína 30 mg
Tramadol	A2	Até 100 mg por unidade, isolado ou associado	RCE	Tramadol 50 mg cápsula
Nalbufina	A2	Até 10 mg de cloridrato por unidade	RCE	Ampola de 10 mg
Ópio	A1	Até 5 mg de morfina anidra por mL	RCE	Elixir paregórico
Oxicodona	A1	Comprimido de liberação controlada até 40 mg	RCE (acima: NR A)	Oxicodona LC 20 mg
Buprenorfina	A1	Adesivo transdérmico de matriz	RCE	Adesivo de buprenorfina
Fenobarbital, barbexaclona	B1	Qualquer apresentação	RCE	Fenobarbital 100 mg
Perampanel	B1	Qualquer apresentação	RCE	Perampanel 4 mg
Carisoprodol	B1	Medicamentos com carisoprodol	Prescrição sem retenção	Associações miorrelaxantes

Substância	Lista	Condição do adendo	Receituário	Exemplo de balcão
Zolpidem	B1	Sem adendo desde 01/08/2024	Notificação B	Zolpidem 5 mg, 10 mg ou 12,5 mg
Cetamina, escetamina	B1	Uso só em estabelecimento de saúde	Não se dispensa em drogaria	Escetamina spray nasal
Produtos de Cannabis	A3	THC até 0,2% (RDC 1.015/2026)	RCE (acima: NR A)	Produto de canabidiol
Medicamento com Cannabis	A3	Até 30 mg/mL de THC e de canabidiol	Notificação A	Spray oromucoso registrado
Loperamida	C1	Qualquer apresentação	Prescrição sem retenção	Loperamida 2 mg
Tetracaína	C1	Odontológico tópico; otológico; oftálmico	Isento; sem retenção; com retenção	Colírio anestésico: retenção
Retinoides tópicos	C2	Uso tópico	Prescrição sem retenção	Tretinoína creme, adapaleno gel
Anabolizantes tópicos	C5	Uso tópico	Prescrição sem retenção	Conforme registro do produto

Texto dos adendos conferido na Portaria 344 consolidada pela Anvisa (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026). Confirme sempre na lista vigente antes de decidir.

SOS Farmácia Comercial

Fluxo de dispensação de controlado

Cliente apresenta receita de medicamento controlado

Identificar substância, concentração por unidade, lista e adendo

DECISÃO

O documento é o exigido pela lista (cor, modelo, título)?

SIM

Seguir para a conferência

NÃO

Recusar e explicar qual receituário é necessário

DECISÃO

A receita é eletrônica?

SIM

Validar assinatura no ITI e consultar o número no SNCR (meio eletrônico, situação autorizada)

NÃO

Se a notificação tiver número do SNCR, consultar (meio físico, prescritor correto)

DECISÃO

Todos os campos preenchidos, legíveis, sem rasura e com quantidade por extenso?

SIM

Conferir prazo e quantidade

NÃO

Recusar e orientar retorno ao prescritor

DECISÃO

Dentro da validade e do limite de quantidade (ou com justificativa)?

SIM

Conferir termos e restrições específicas

NÃO

Recusar ou dispensar só o permitido, conforme o caso

ATENÇÃO

Receita rasurada, número cancelado ou divergente do prescritor indicam possível fraude

Identificar o comprador com documento e registrar nome, CPF, endereço e telefone

↓

Dispensar, anotar quantidade no verso, carimbar e reter a via da farmácia (ou registrar uso no SNCR)

↓

Lançar no sistema da loja e transmitir ao SNGPC no prazo

↓

Orientar o paciente sobre uso, riscos e guarda do medicamento

Checklist de conferência da Notificação de Receita

- ◯ Confirmar que a cor e o tipo da notificação correspondem à lista do medicamento
- ◯ Verificar se o modelo é oficial (antigo, versão 1 ou versão 2 impressos na vigência)
- ◯ Consultar no SNCR o número de padrão nacional: idêntico, autorizado, tipo e meio corretos
- ◯ Conferir se o prescritor vinculado ao número é o emitente do documento
- ◯ Conferir nome, conselho, UF, endereço e assinatura do prescritor
- ◯ Conferir nome e CPF do paciente (ou passaporte ou "não possui")
- ◯ Conferir DCB, concentração, forma farmacêutica e posologia
- ◯ Conferir quantidade em algarismos e por extenso, iguais entre si
- ◯ Verificar ausência de emenda, rasura ou corretivo
- ◯ Confirmar uma única substância na notificação
- ◯ Contar os dias desde a emissão: até 30 dias (talidomida: 20)
- ◯ Calcular os dias de tratamento e comparar com o limite da lista
- ◯ Exigir justificativa com CID se a quantidade passar do limite
- ◯ Verificar termos obrigatórios (B2, retinoides, talidomida, fenfluramina)

- ◯ Em papel, conferir a receita que acompanha a notificação e devolvê-la carimbada
- ◯ Registrar nome, CPF, endereço e telefone do comprador
- ◯ Anotar no verso a quantidade dispensada e carimbar com dados da farmácia, data e atendente
- ◯ Reter a notificação e arquivá-la por tipo e mês

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual norma regulamenta os medicamentos controlados no Brasil?	Portaria SVS/MS 344/1998, detalhada pela Portaria SVS/MS 6/1999, com listas atualizadas por RDC.
Qual RDC fez a atualização mais recente do Anexo I até outubro de 2026?	RDC 1.036, de 9 de julho de 2026 (Atualização nº 101).
Validade e abrangência da Notificação A?	30 dias da emissão, em todo o território nacional.
Quantidade máxima na Notificação A?	5 ampolas ou 30 dias de tratamento.
Quantidade máxima na Notificação B?	5 ampolas ou 60 dias de tratamento.
Quantas substâncias cabem numa notificação?	Uma substância ou um medicamento.
Quantas substâncias da C1 cabem numa RCE?	Até 3, cada uma limitada a 60 dias (anticonvulsivantes e antiparkinsonianos: 6 meses).
Validade da notificação de talidomida?	20 dias, em todo o território nacional (RDC 11/2011, redação da RDC 873/2024).
Receituário do zolpidem 10 mg?	Notificação de Receita B, desde 1º de agosto de 2024, em qualquer concentração.
Receituário de paracetamol + codeína 30 mg?	RCE em 2 vias (adendo 2 da lista A2).
O que aconteceu com a lista C4?	Foi extinta pela RDC 103/2016; antirretrovirais saíram da 344.
Receita de controlado de outro estado precisa de visto da VISA?	Não. A RDC 873/2024 revogou o visto. Só a receita de emergência vai à VISA em 72 horas.
Quem imprime o talonário amarelo desde fevereiro de 2026?	O prescritor ou a instituição, em gráfica, com numeração da VISA gerada no SNCR.
Qual assinatura exige a Notificação eletrônica?	Assinatura qualificada ICP-Brasil.
Desde quando há Notificação de Receita eletrônica?	30 de setembro de 2026 (RDC 1.000/2025, art. 16, redação da RDC 1.028/2026).

Pergunta	Resposta
O que a farmácia faz com receita eletrônica no SNCR?	Valida a assinatura no ITI, confere o número e registra a utilização.
Prazo de transmissão do SNGPC?	Arquivos a cada 1 a 7 dias, mesmo sem movimentação (RDC 22/2014, art. 10).
Por quanto tempo guardar receitas e documentos de controlados?	2 anos (Portaria 344, art. 64).
Onde guardar os controlados?	Sob chave ou dispositivo seguro, em local exclusivo, sob responsabilidade do farmacêutico (art. 67).
Faixa de multa de infração grave na Lei 6.437/1977?	R$ 75.000 a R$ 200.000; dobra na reincidência.

Questões de fixação

1. Cliente apresenta Receita de Controle Especial em duas vias com zolpidem 10 mg, 30 comprimidos, emitida há 5 dias. Qual a conduta correta em outubro de 2026?

A Dispensar, porque apresentações de até 10 mg seguem em RCE

B Dispensar metade e reter a 1ª via

C Recusar, porque o zolpidem exige Notificação de Receita B

D Dispensar e comunicar a VISA em 72 horas

E Recusar, porque o zolpidem exige Notificação A

2. Sobre a Notificação de Receita A após a RDC 1.000/2025, assinale a correta.

A Continua impressa exclusivamente pela Vigilância Sanitária, que carimba cada folha

B Pode ser impressa em gráfica pelo prescritor, com numeração da VISA

C Dispensa numeração oficial quando impressa em gráfica privada

D Passou a ter validade de 60 dias para todas as listas A

E Só vale na unidade federativa que concedeu a numeração

3. Paciente traz Notificação B de clonazepam 2 mg, 1 comprimido à noite, 90 comprimidos, sem nenhum documento adicional. O farmacêutico deve:

A Dispensar os 90 comprimidos, pois a Notificação B não tem limite de quantidade

B Dispensar, porque a Notificação B vale 60 dias e cobre o tratamento

C Exigir que o paciente traga uma Notificação A no lugar da B

D Exigir justificativa com CID ou diagnóstico para os 90 comprimidos

E Dispensar os 90 e reter também a receita comum que acompanha

4. Uma drogaria em Recife recebe Receita de Controle Especial de sertralina emitida por médico de São Paulo. Qual procedimento está correto?

A Levar a 1ª via à VISA em 72 horas para visto

B Recusar, porque a RCE só vale no estado de emissão

C Exigir notificação azul por ser de outro estado

D Pedir carimbo da VISA de São Paulo

E Conferir os requisitos e dispensar normalmente, sem visto

5. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o medicamento e o receituário.

A Paracetamol 500 mg + codeína 30 mg: Receita de Controle Especial

B Metilfenidato 10 mg comprimido: Receita de Controle Especial

C Fenobarbital 100 mg comprimido: Notificação de Receita B

D Isotretinoína 20 mg cápsula: Receita de Controle Especial

E Tretinoína creme 0,05%: Notificação especial de retinoides

6. Sobre a validade das notificações vigente em 2026, é correto afirmar:

A Notificação de talidomida: 30 dias, só na unidade federativa de emissão

B Notificação de talidomida: 20 dias, em todo o território nacional

C Notificação B: 60 dias, em todo o território nacional

D Notificação de retinoides: 15 dias, em todo o território nacional

E Notificação A: 30 dias, só na UF de emissão e com visto da VISA

7. Uma farmácia recebe Notificação B eletrônica em 05/10/2026. Qual sequência atende à RDC 1.000/2025?

A Imprimir o PDF, carimbar o verso e reter a cópia, sem consulta a sistema

B Exigir a via em papel, porque notificação não pode ser eletrônica

C Validar a assinatura no ITI, consultar o número no SNCR e registrar o uso

D Aceitar assinatura gov.br e registrar a venda somente no SNGPC

E Dispensar e registrar o uso apenas no sistema da plataforma emissora

8. Em relação ao SNGPC, assinale a correta.

A A transmissão é mensal, até o dia 15

B Semanas sem venda de controlados dispensam envio de arquivo

C Qualquer atendente pode gerar e enviar o XML

D O SNCR substituiu o SNGPC a partir de 30/09/2026

E Os arquivos devem ser enviados a cada 1 a 7 dias, mesmo sem movimentação

9. Na consulta de uma Notificação A em papel, o SNCR exibe a situação "não atribuída ao prescritor". O farmacêutico deve:

A Não dispensar e orientar a regularização da numeração com a VISA

B Dispensar, porque a numeração existe na base nacional do SNCR

C Dispensar e registrar a utilização da notificação no SNCR

D Dispensar metade da quantidade até a regularização

E Reter a notificação e enviá-la ao Conselho de Medicina

10. Durante inspeção, a VISA verifica que o estoque físico de alprazolam diverge do saldo no SNGPC e que a última transmissão foi há 15 dias. A farmácia já havia sido multada pela mesma conduta. Sobre a penalidade, é correto:

A Cabe apenas advertência, por ser infração leve

B A multa máxima possível é de R$ 75.000

C A reincidência é agravante e a multa é aplicada em dobro

D Não há infração, pois o SNGPC está suspenso desde 2021

E Só o Conselho Regional de Farmácia pode punir

11. Sobre a guarda e a escrituração de controlados em drogaria, assinale a correta.

A Podem ficar em gôndola fechada com vidro, longe do balcão

B O livro de registro específico continua obrigatório junto com o SNGPC

C Os documentos de controlados podem ser descartados após 6 meses

D Ficam sob chave em local exclusivo, com estoque idêntico ao do SNGPC

E A drogaria pode fracionar a embalagem se o paciente pedir

12. Paciente de 24 anos apresenta Notificação de Receita B2 de sibutramina 15 mg, 1 cápsula ao dia, 60 cápsulas, com o Termo de Responsabilidade do Prescritor. Qual a conduta?

A Recusar, porque a B2 permite só 30 dias para qualquer substância

B Recusar, porque a dose diária máxima é 10 mg

C Dispensar sem reter o termo

D Dispensar, preencher os campos da farmácia no termo e reter uma via

E Exigir Notificação A

Gabarito comentado

1. **C**. O zolpidem está na lista B1 sem adendo desde 1º/08/2024, quando a Anvisa excluiu a exceção para até 10 mg; toda apresentação exige Notificação B. A alternativa A descreve a regra revogada. Não há dispensação parcial nem comunicação que corrija o receituário errado. Notificação A é para as listas A.
2. **B**. A RDC 1.000/2025 deu ao art. 40 da 344 a redação que permite a impressão em gráfica pelo profissional ou instituição; a impressão pela VISA virou faculdade. A numeração continua obrigatória e vem do SNCR. A validade segue em 30 dias e é nacional desde a RDC 873/2024.
3. **D**. A Notificação B cobre até 60 dias de tratamento; 90 comprimidos a 1 por dia são 90 dias. Acima do limite, o prescritor deve entregar justificativa (Portaria 344, art. 46, § 1º). A validade da Notificação B é de 30 dias, não de 60. Clonazepam é B1, não A.
4. **E**. A RCE vale em todo o território nacional, e a RDC 873/2024 revogou o § 3º do art. 52 da 344, que exigia visto para receitas de outra UF. Sertralina é C1 e usa RCE. Visto em 72 horas permanece apenas para a receita de emergência.
5. **A**. Codeína até 100 mg por unidade cai no adendo 2 da A2 e usa RCE. Metilfenidato (A3) exige Notificação A. Fenobarbital tem adendo na B1 e usa RCE. Isotretinoína oral exige notificação especial de retinoides. Retinoide tópico é prescrição sem retenção (adendo 2 da C2).
6. **B**. A RDC 873/2024 deu ao art. 21, § 2º, da RDC 11/2011 a redação de 20 dias em todo o território para a talidomida. A Notificação B vale 30 dias. Retinoides: 30 dias. A Notificação A vale 30 dias em todo o país desde a mesma RDC.
7. **C**. O art. 13 da RDC 1.000/2025 manda verificar a assinatura pelo ITI, conferir a numeração concedida no SNCR e registrar a utilização. Desde 30/09/2026 notificações podem ser eletrônicas. Notificação exige assinatura ICP-Brasil; gov.br é avançada. O registro na plataforma emissora não substitui o SNCR, e o SNGPC continua obrigatório em paralelo.
8. **E**. RDC 22/2014, art. 10, § 3º: intervalo mínimo de 1 e máximo de 7 dias, ainda que sem movimentação. A geração e o envio são funções do farmacêutico RT (art. 18). O SNCR controla a receita e coexiste com o SNGPC. Envio mensal até o dia 15 é a regra da RMNRA, não do SNGPC.
9. **A**. Número gerado mas não atribuído a prescritor ou instituição não pode ser usado (cartilha da Anvisa, 2026). A existência do número não basta. Receita em papel não tem registro de uso no SNCR. Não existe dispensação parcial como saída para numeração irregular.
10. **C**. A Lei 6.437/1977 aplica a multa em dobro na reincidência (art. 2º, § 2º), e a reincidência é agravante (art. 8º, I). A suspensão da RDC 586/2021 terminou com o cronograma de 2025 e 2026. A VISA aplica a sanção sanitária; o conselho pode abrir processo ético à parte.
11. **D**. Portaria 344, art. 67 (guarda sob chave em local exclusivo) e RDC 22/2014, art. 15 (estoque idêntico ao escriturado). O SNGPC substitui o livro (art. 35). Documentos ficam 2 anos (art. 64 da 344). Drogaria não fraciona controlado (art. 79).
12. **D**. A RDC 50/2014 (redação da RDC 133/2016) permite à sibutramina até 60 dias de tratamento e fixa dose máxima de 15 mg/dia. A farmácia preenche seus campos no termo, retém uma via e entrega outra ao paciente (art. 11). Sibutramina é B2, não A.